

UNITÉ PÉDAGOGIQUE

METHODES ET TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

*" Je suis étudiant à l'INFAS pour être un agent de santé nouveau.
Je suis responsable de mon apprentissage.
Je m'engage à devenir un agent de santé nouveau afin de prodiguer
des soins humanisés de qualité. "*



L1
TC

**SAGE-FEMME / MAÏEUTICIEN
INFIRMIER, INFIRMIERE**

2025- 2026



Yemouma

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : SOINS INFIRMIERS GENERAUX	4
L'ACCUEIL DU MALADE	5
VISITES AUX MALADES	8
CHAMBRE DU MALADE	10
REPOS DU MALADE	13
REFECTION DU LIT DU MALADE	15
PORT DE GANTS PROPRES ET STERILES	18
 CHAPITRE 2 : SOINS INFIRMIERS DE BASE	 22
TOILETTE GENERALE DU MALADE	23
SOINS DE L'ESCARRE OU ULCERE DE DECUBITUS	26
SOINS D'HYGIENE DES CAVITES NATURELLES	32
INSTALLATION ET DIVERSES POSITIONS DU MALADE DANS LE LIT	35
 CHAPITRE 3 : SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION DE THERMOREGULATION	 40
THERMOREGULATION	40
TEMPERATURE CORPORELLE ET LE THERMOMETRE MEDICAL	42
FEUILLE DE TEMPERATURE	44
VESSIE DE GLACE	46
BOUILLLOTTE	48
COUP DE CHALEUR	50
INSOLATION	51
SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION LOCOMOTRICE	52
PREPARATION DU CHARIOT DE SOINS	52
PANSEMENTS	55
BANDAGE	59
IMMOBILISATIONS PROVISOIRES	61
SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION CARDIO-VASCULAIRE	64
MESURE DE LA PULSATION OU POULS	64
MESURE DE LA TENSION OU PRESSION ARTERIELLE	66

INJECTIONS PARENTERALES	68
INJECTION INTRADERMIQUE	70
INJECTION SOUS-CUTANEE	71
INJECTION INTRA-MUSCULAIRE (IM)	73
INJECTION INTRA-VEINEUSE (IV)	75
INJECTION LENTE PAR DISPOSITIF INTRAVEINEUX	77
PRELEVEMENT DE SANG PAR PONCTION VEINEUSE	80
PERFUSION INTRAVEINEUSE	82
SÉCURITÉ DES INJECTIONS ET IMPACT DES INJECTIONS A RISQUE	85
CALCUL DES DOSES ET POURCENTAGE DES MEDICAMENTS	89
 CHAPITRE 4 : SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION URINAIRE	 92
GENERALITES	92
RECUEIL DES URINES POUR ANALYSE	93
SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION DIGESTIVE	94
CONTROLE DE L'EVACUATION INTESTINALE RECUEIL ET SURVEILLANCE DES SELLES	94
LES LAVEMENTS EVACUATEUR ET MEDICAMENTEUX	97
SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION RESPIRATOIRE	100
AIDE A LA VENTILATION	100
OXYGENOTHERAPIE	103
NOTIONS D'URGENCES MEDICALES INFIRMIERES	107
 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	 111

CHAPITRE 1 :

SOINS INFIRMIERS GENERAUX

L'ACCUEIL DU MALADE

OBJECTIF GENERAL

Comprendre l'accueil du malade en milieu clinique.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir l'accueil.
2. Déterminer le but de l'accueil.
3. Expliquer le rôle de l'Infirmier dans l'accueil du malade.

INTRODUCTION

L'accueil d'un malade à l'hôpital est, pour l'agent de santé (INFAS), un fait quotidien. L'agent de santé doit faire de l'accueil du malade un élément important de son travail. Il doit tenir compte de la mentalité du patient et de ses parents. Devant la crainte, l'inconnu, l'incertain, l'incertitude, la douleur de la séparation, l'attitude de l'agent de santé doit témoigner de compréhension, et créer une atmosphère de confiance et de sécurité ; Car la première impression peut influencer le bien être de tout le séjour du malade à l'hôpital.

I. DEFINITION

Qui dit « accueil » dit réception d'un hôte que l'on attend. L'hôte attendu c'est le malade auquel s'attache une psychologie toute spéciale empreinte de sensibilité extrême.

L'accueil d'un malade est une activité qui consiste à recevoir une personne qui vient pour une consultation, un soin, ou une hospitalisation en vue de la mettre dans des conditions idoines au cours de son passage dans une structure sanitaire.

II. BUT

L'accueil a pour but d'amoindrir, de réparer, de soulager en quelque sorte le mal causé par la maladie (séparation familiale, la souffrance).

« C'est la première impression qui compte » dit le langage populaire.

Le soignant doit alors donner une bonne impression au malade dès leur première rencontre. Un certain nombre de démarche est nécessaire pour que le malade se sente à l'aise. Le soignant a un rôle primordial dans l'accueil.

Le diagnostic infirmier sera : un déficit de connaissances sur les problèmes liés à l'hospitalisation ou au mal causé par la maladie ; et le rejet de l'environnement sanitaire et/ou des soignants.

Les besoins à satisfaire sont : apprendre, éviter les dangers.

III. LE ROLE DE L'INFIRMIER OU DE LA SAGE FEMME

Il est de plusieurs ordres :

- **Le domaine administratif**

L'infirmier ou la sage-femme doit diriger le malade et sa famille avec amabilité, vers le service ou l'agent chargé des formalités administratives :

- Diriger le malade vers l'hospitalisation,
- Identifier les personnes chargées de le prendre en charge,
- Conseiller pour bien garder argent, bijoux ou autres objets de valeurs.

- **Le domaine Hygiénique**

- Distribuer le linge et le matelas au malade ou donner les consignes nécessaires,
- Lui indiquer la place pour les vêtements, les objets de toilettes,
- Lui désigner la sonnette, les toilettes etc....
- Lui faire connaître les habitudes de la maison, et à sa famille, les heures de repas, des visites (heures, fréquence, nombre de personnes),
- Demander au malade si nécessaire d'aller prendre son bain ou le nettoyer,
- Faire le lit du malade et l'installer,
- Mettre à sa disposition : table de nuit, urinal, crachoir....

- **Le domaine Médical et de la surveillance**

- Prendre la température, les pulsations et parfois la respiration et inscrire (si possible) sur la feuille de température, le peser,
- Lui indiquer où prendre les tubes d'examen ou les mettre à sa disposition,
- Noter les observations,
- Prendre connaissance du régime,
- Préparer le nécessaire pour l'examen médical ou la visite.

- **Le domaine relationnel et conseil**

- Indiquer au malade le bureau pour effectuer les modalités de sortie,
- Veiller à ce que le malade emporte tous ses effets et ne pas, par erreur, des objets appartenant au service,
- Si nécessaire l'aider à faire ses bagages,
- Lui donner des conseils nécessaires pour conserver sa santé et des indications pour ses médicaments, son régime...

L'agent de santé est tenu au secret professionnel sur tout ce qu'il (elle) apprend au sujet du malade et de sa famille.

- **Qualités humaines**

Certaines vont de soi : politesse, ponctualité, amabilité, tenue et attitude correcte. D'autres vertus sont importantes ; l'écoute active et attentive, la discrétion. Le malade doit se sentir reconnu, ne pas se sentir comme un étranger, un inopportun. Lancer alors une petite phrase de reconnaissance qui l'aidera à se sentir à l'aise et à attendre.

- **Conditions matérielles d'un bon accueil**

- L'apparence du service a un effet sur le patient. Il émanera quelque chose de sympathique et attrayant d'un établissement hospitalier où on aura planté des haies, des parterres de fleurs et dont les murs auront été repeints, crépis ou chaulés.
- La propreté et l'hygiène des lieux. Cela implique que soient installés un ou plusieurs bidons recouverts servant de poubelles, placés ni trop près ni trop loin des salles d'hospitalisation, à des endroits évitant des nuisances et le contenu vidé et détruit.
- Le confort du malade sera périodiquement réévalué.
- La discrétion doit être assurée.
- La perturbation sonore doit être réduite au maximum, puisque le matin entre huit heures et midi, une foule de gens qui attendent, discutent et s'énervent à cause des resquilleurs.

CONCLUSION

L'accueil des malades n'est pas que politesse ou gentillesse, mais en grande partie, écouter et organiser l'attente, le confort de ceux qui patientent et la discrétion des consultations.

Un accueil agréable fera beaucoup pour la qualité et la réputation du centre médical. Certes, toutes les propositions précédentes ne sont pas des recommandations, mais nous souhaitons que ce cours sensibilise à la notion d'accueil et surtout vous invite à réfléchir à votre propre accueil dans votre lieu de travail. Car l'entrée d'un malade à l'hôpital est, un univers nouveau pour lui. Par conséquent aucun domaine ne doit être négligé afin de lui permettre de s'insérer sans avoir « le mal d'hospitalisation ».

Il répond aux besoins d'apprendre et d'éviter le danger selon Virginia Henderson.

VISITES AUX MALADES

OBJECTIF GENERAL

Connaitre la visite aux malades.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir la visite aux malades.
2. Déterminer le but de la visite aux malades.
3. Enumérer les attitudes à adopter.
4. Déterminer les caractéristiques d'une visite.
5. Citer les effets de la visite sur un malade.

I. DEFINITION

La visite à une personne malade est une action qui consiste à aller voir celle-ci par civilité ou par devoir.

II. BUT

Réconforter et soutenir celui qui est souffrant.

III. ATTITUDES A ADOPTER AU COURS D'UNE VISITE A UN MALADE :

- Celui qui vient auprès d'un malade ne doit pas adopter une attitude qui pourrait le nuire ou lui occasionner une gêne quelconque. Au cours de la visite, il ne faut pas aborder des sujets qui pourraient indisposer le malade ;
- Eviter à tout prix les questions, les remarques ou les allusions qui pourraient raviver chez le malade certaines peines ou souffrances ;
- Il est également bien, dans la mesure du possible, de proposer son aide au malade, et lui demander s'il désire quelque chose.
- Il faut dans la mesure du possible, adopter une attitude réconfortante à l'égard du malade (comme par exemple masser son visage ou l'endroit du corps qui le fait souffrir), mais lui tenir des propos encourageants sur son état.

IV. CARACTERISTIQUES D'UNE VISITE

La visite doit être relativement brève. En effet, la présence prolongée de quelqu'un à ses côtés peut incommoder plus ou moins fortement le malade, suivant son état. Par ailleurs, ce dernier préfère souvent que ce soit ceux qui sont les plus proches de lui (enfants, parents, amis intimes, époux ou épouse...) qui restent à ses côtés. Néanmoins, si le malade exprime lui-même le désir que la personne qui vient le voir reste plus longtemps, dans ce cas, il n'y a aucun problème.

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services et la visite doit se faire à une heure appropriée.

V. EFFETS DES VISITES SUR LES MALADES

• Sur celui qui reçoit

La visite à un malade peut être une distraction non seulement agréable mais aussi salutaire. A l'opposé, il est des visiteurs dont la venue est mal accueillie ou dont la personne quoique agréable finit par nuire au malade.

• Sur les autres malades

La gêne provoquée par le son des voix, le bruit, les allées et venues, le grand nombre de visiteurs, la poussière soulevée, intensifient la souffrance des autres malades.

- Dispositions à adopter ;
- Connaitre ses malades ;
- Contrôler les visites ;
- Assurer le contrôle du respect des textes.

CHAMBRE DU MALADE

OBJECTIF GENERAL

Comprendre l'organisation d'une chambre.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Décrire la chambre du malade.
2. Citer tout le mobilier nécessaire de la chambre du malade.
3. Identifier le matériel d'entretien d'une chambre.

INTRODUCTION

La chambre du malade, individuelle ou commune est le lieu où le malade, abandonnant son cadre habituel, va passer un séjour plus ou moins long. Ainsi, nous aurons une chambre d'accès facile permettant une surveillance régulière pour les cas graves et une chambre agréable, calme et ensoleillée pour les cas chroniques.

L'infirmier ou la sagefemme devra donc préparer la chambre en vue de réserver un agréable accueil au malade.

I. DESCRIPTION

En général, la chambre devra être spacieuse, confortable, agréable, aérée, gaie, bien éclairée, ordonnée et propre. Dans les hôpitaux, elle est conçue pour 1, 2, 3 voire 5 lits. Dès lors une chambre qui répond aux normes est un allié dans la prestation des soins de qualité.

Elle doit être un formidable outil pour contrer la propagation des germes dans un hôpital. Elle doit être adaptée aux réalités du personnel et faciliter la mise en place de saines habitudes.

1.1. La salle d'eau ou box sanitaire

Elle doit renfermer :

- Un lavabo en porcelaine ;
- Un bidet ;
- Une cuvette de WC ;
- Un vidoir ;
- Une douche ;
- Un miroir ;
- Un porte savon ;
- Une porte serviette ;
- Un éclairage parfait.

1.2. Les murs

Ils doivent être recouverts de carreaux ou de peinture lavable de couleur gaie apaisante.

1.3. Le sol

Il sera recouvert en matériaux faciles à nettoyer, de préférence carrelé (grands carreaux).

1.4. L'aération

Facteur important de salubrité, l'aération est assurée soit par des vitres en chicanes réalisant une ventilation indirecte et permanente soit par des fenêtres assurant un renouvellement rapide de l'air.

1.5. L'éclairage

Il est fourni soit par la lumière naturelle des rayons solaire apportant la lumière et la chaleur soit par la lumière artificielle des ampoules électriques placées souvent au plafond, à la tête du lit ou au bas du mur.

II. MOBILIER

Il est composé généralement de :

- Un lit et ses accessoires ;
- Une table de chevet (table de nuit placée à côté du lit) ;
- Une table de lit ;
- La literie (matelas, coussin, traversin, draps, alèses, couverture, couvre-lit)
- Une chaise ;
- Un fauteuil ;
- Une armoire.

A ce mobilier peut s'ajouter parfois des appareils électroménagers quand il s'agit de chambre individuelle :

- Un réfrigérateur ;
- Un ventilateur ;
- Un poste téléviseur.

III. MATERIEL USUEL

Le matériel est spécifique à chaque service mais il s'agit en général de :

- Une potence ;
- Un urinal ;
- Un bassin de lit ;
- Un crachoir ;
- Un bocal.

IV. ENTRETIEN DE LA CHAMBRE

L'entretien de la chambre est fait chaque matin par les filles de salle et les techniciens de surface.

Les murs et les vitres seront lavés à l'eau savonneuse tous les quinze jours ou au moins une fois par mois.

Le sol sera nettoyé avec une serpillière imbibée d'eau savonneuse tous les matins. Le box sanitaire sera désinfecté à l'eau de javellisée au moins deux fois par semaine.

Les tables seront nettoyées après chaque repas.

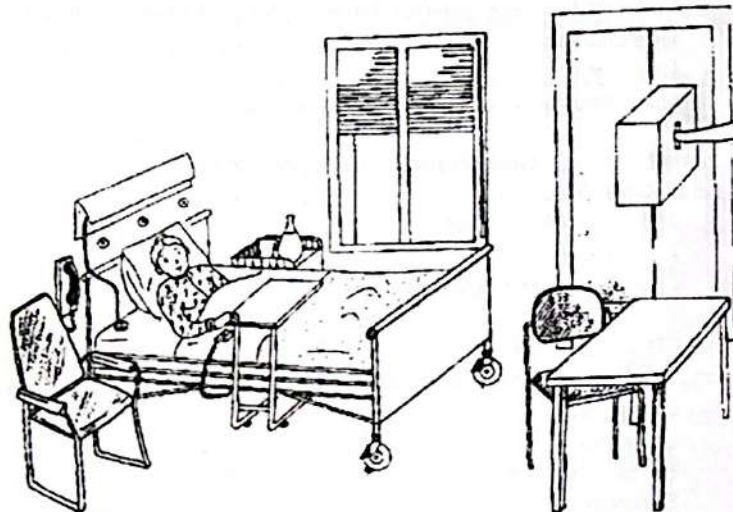
Les bassins, les crachoirs, les bœaux seront vidés et lavés après leur utilisation. Ils seront désinfectés une fois par semaine. Les potences, les chaises et les lits seront nettoyés une fois par semaine.

CONCLUSION

La chambre du malade est sa nouvelle demeure qui lui est imposée à cause de son état pathologique.

Le confort de la chambre contribue à la guérison du malade ; il est donc important que celle-ci soit nettoyée régulièrement, rangée.

L'infirmier doit veiller à ce que tout soit fait selon les règles d'hygiène afin de satisfaire le besoin de sécurité du malade.



CHAMBRE D'HOSPITALISATION

REPOS DU MALADE

OBJECTIF GENERAL

Comprendre le repos du malade.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir le repos du malade.
2. Identifier les facteurs favorisant le repos du malade.

INTRODUCTION

On ne peut parler de repos sans songer au sommeil. C'est le sommeil qui procure le grand repos. Il est réparateur et donne la force. Les heures de repos varient selon les individus, la condition de vie et de climat.

I. DEFINITION

Dans le domaine infirmier, le repos fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Le malade a besoin d'autant de repos que de médicaments pour retrouver les forces et santé.

II. FACTEURS FAVORISANTS LE REPOS

- Confort de la pièce ;
- La tension ambiante doit être agréable ;
- La pièce doit être propre, aérée et sans désordre ;
- Le degré de luminosité convenable ;
- Lit avec un matelas confortable ;
- Absence de bruit ;
- Absence de souci majeur.

III. CONDITION D'UN BON DE REPOS

- Organisation du service
 - Respecter et faire respecter les heures de visites ;
 - Veiller à ce que le personnel soit discipliné ;
 - Ne pas faire de bruit (conservation bruyante, grand nettoyage aux heures indues, manipulation de matériel) ;
 - Eduquer les malades et leur famille pour le respect des autres ;
 - Eviter de discuter à haute voix, de traîner les pas en marchant ;
 - Les services d'intendance seront situés en fonctions des services d'hospitalisation de manière à ne pas perturber les malades au moment du repos.

- **Organisation des soins**

- Suivre autant que possible les habitudes du malade ;
- Ne pas le réveiller, ni l'appeler à n'importe quelle heure ;
- Éviter les allées et venues auprès du malade (au lit) ;
- Essayer de créer une ambiance agréable autour du malade ;
- Veiller au confort : réfection du lit tous les jours avec soins d'hygiène.

- **Education du malade et ou de ses parents**

- Amener le malade à éduquer ses parents par rapports aux priorités des lieux, des locaux et au repos des autres malades ;
- Discipliner les parents du malade à respecter le régime alimentaire, le repos et le traitement prescrit.

REFECTION DU LIT DU MALADE

OBJECTIF GENERAL

Connaitre la réfection du lit du malade.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Donner les buts de la réfection de lit.
2. Citer les différentes sortes de lits.
3. Décrire la technique de réfection de lit non occupé.
4. Décrire la technique de réfection de lit occupé.

INTRODUCTION

Le lit est de façon générale est préparé pour que l'on puisse s'y étendre et y dormir. Mais à l'hôpital, le lit permet au malade de se reposer, de faire sa surveillance et son traitement. A cet effet il doit être tenu avec art pour le bien être du malade. Le lit doit être fait tous les jours, après la toilette, chaque fois que le besoin se fait sentir.

I. DEFINITION

La réfection de lit occupé consiste à changer le linge sale du lit du malade impotent (qui ne peut pas bouger) par du linge propre.

La réfection de lit non occupé consiste à mettre un linge propre en vue d'installer un malade.

II. BUTS

- Procurer un confort au malade hospitalisé ;
- Assurer la sécurité du malade (propreté du lit, environnement) ;
- Maintenir une hygiène quotidienne ;
- Prévenir les escarres ;
- Favoriser le confort et la sécurité du malade ;
- Permettre au personnel infirmier de faire tous les autres soins dans un environnement agréable.

III. INDICATIONS

Tout malade hospitalisé, en particulier les malades incontinents.

IV. LES DIFFERENTS LITS

Ce sont des lits à particularités : roulette à freins, matelas ou médicalisé (tête, pied), à hauteur réglable, à retournement (blessés à la colonne vertébrale), lit pathologie (pour les grands brûlés).

- **Organisation des soins**

- Suivre autant que possible les habitudes du malade ;
- Ne pas le réveiller, ni l'appeler à n'importe quelle heure ;
- Eviter les allées et venues auprès du malade (au lit) ;
- Essayer de créer une ambiance agréable autour du malade ;
- Veiller au confort : réfection du lit tous les jours avec soins d'hygiène.

- **Education du malade et ou de ses parents**

- Amener le malade à éduquer ses parents par rapports aux priorités des lieux, des locaux et au repos des autres malades ;
- Discipliner les parents du malade à respecter le régime alimentaire, le repos et le traitement prescrit.

REFECTION DU LIT DU MALADE

OBJECTIF GENERAL

Connaitre la réfection du lit du malade.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Donner les buts de la réfection de lit.
2. Citer les différentes sortes de lits.
3. Décrire la technique de réfection de lit non occupé.
4. Décrire la technique de réfection de lit occupé.

INTRODUCTION

Le lit est de façon générale est préparé pour que l'on puisse s'y étendre et y dormir. Mais à l'hôpital, le lit permet au malade de se reposer, de faire sa surveillance et son traitement. A cet effet il doit être tenu avec art pour le bien être du malade.

Le lit doit être fait tous les jours, après la toilette, chaque fois que le besoin se fait sentir.

I. DEFINITION

La réfection de lit occupé consiste à changer le linge sale du lit du malade impotent (qui ne peut pas bouger) par du linge propre.

La réfection de lit non occupé consiste à mettre un linge propre en vue d'installer un malade.

II. BUTS

- Procurer un confort au malade hospitalisé ;
- Assurer la sécurité du malade (propreté du lit, environnement) ;
- Maintenir une hygiène quotidienne ;
- Prévenir les escarres ;
- Favoriser le confort et la sécurité du malade ;
- Permettre au personnel infirmier de faire tous les autres soins dans un environnement agréable.

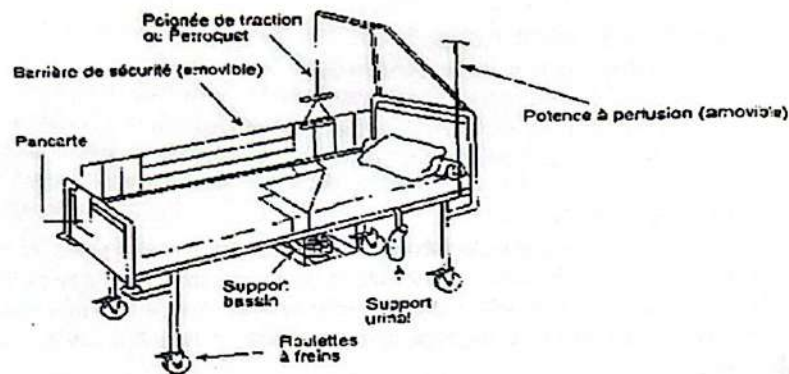
III. INDICATIONS

Tout malade hospitalisé, en particulier les malades inconscients.

IV. LES DIFFERENTS LITS

Ce sont des lits à particularités : roulette à freins, matelas ferme et plastifié, articulé ou médicalisé (tête, pied), à hauteur réglable, à barrières, potence, lit à retournement (blessés à la colonne vertébrale), lit spécial en fonction de la pathologie (pour les grands brûlés).

Exemples : Le lit articulé : il permet de modifier à volonté la position du patient.



Un lit d'hôpital

- Le lit basculant (même rôle que le lit articulé) ;
- Le lit mécanique Dupont : permet de soutenir plus facilement le malade immobilisé lors qu'il s'agit de lui administrer des soins ou faire sa toilette ;
- Le lit Guatheron : permet de tourner et de maintenir le malade sur le côté grâce au poignet fixé au lit ;
- Le lit à inclinaison latéral : permet de modifier la position du malade sans le bouger.

1. Les accessoires du lit

Ils sont nombreux et assurent la sécurité et le confort du malade et facilitent l'exécution des soins. Ce sont : la potence, les cales butoir, les grilles de sécurité (lit d'enfants), les galeries de côtés, les porte-bassins, portes urinal, les sonnettes, etc.

2. Les matelas

Ils peuvent être en crin, en laine, pneumatique ou en mousse de latex. En général, le matelas du lit du malade ne doit être ni trop rigide ni trop souple. Il est recouvert d'un outil solide et doit être enveloppé d'une housse imperméable.

V. REFECTION DE LIT NON OCCUPE

1- Matériel

- Deux draps propre (un drap de dessus, un drap de dessous) ;
- Une couverture ;
- Un couvre-lit ;
- Deux alèzes (coton, toile cirée) ;
- Des oreillers ;
- Un chariot ou deux chaises.

2- Technique (voir TP)

VI. REFECTION DE LIT OCCUPE

1- Préparation du soin

Aller évaluer le degré d'autonomie du patient

S'il est conscient lui expliquer le soin

Rassurer le patient pour dissiper sa crainte.

2- Matériel

- Deux draps propres ;
- Une couverture ;
- Un couvre-lit ;
- Deux alèzes (coton, toile cirée) ;
- Un chariot ou deux (2) chaises ;
- Un sac à linge.

3- Technique (voir TP)

CONCLUSION

La réfection de lit est un acte de soin qui assure au malade un mieux-être. Elle contribue à la qualité de la prestation des services et valorise l'intervention infirmière dans la statistique des besoins de dépendance du client.

IV. RÔLE

- Ils établissent une barrière étanche entre le patient et l'opérateur ;
- Barrière bactériologique protégeant à la fois l'un et l'autre ;
- Barrière physique (protection contre les piqûres et coupures).

V. INDICATIONS :

Ils sont réservés :

- aux actes chirurgicaux et aux techniques invasives médicales (pose de drain thoracique, biopsies, ponctions...) ;
- aux techniques invasives infirmières (sondage vésical, réfection de certains pansements, manipulation de chambre implantable...).

VI. TEMPS D'UTILISATION

Les gants stériles doivent être changés régulièrement en cours d'intervention pour respecter à la fois l'asepsie des différents temps opératoires et les risques de micro-trous au bout d'un temps moyen d'utilisation.

Des études ont prouvé que le gant devenait poreux au cours de l'intervention même en l'absence de perforation. Un double gantage est recommandé au bloc opératoire selon le type d'intervention.

VII. COMMENT PORTER DES GANTS STÉRILES ?

Ceux qui travaillent dans le domaine médical doivent porter des gants stériles presque tout le temps et doivent le faire correctement. Les mettre comme il se doit a pour avantage de prévenir la transmission et la contraction de maladies infectieuses, que ce soit au patient ou au prestataire de soins.

Vous pourrez vous assurer de bien les porter en vous lavant les mains et en les faisant glisser à l'intérieur des gants une fois qu'elles seront sèches.

Veiller à ce que les mains soient propres.

1. Prenez des gants dont la taille vous correspond

Pour savoir si les gants que vous avez choisis sont de la bonne taille, vous devez vous assurer qu'ils :

- vous permettent de bouger vos doigts confortablement ;
- ne se frottent pas contre votre peau ;
- ne fassent pas transpirer les mains ;
- ne fatiguent pas les muscles des mains.

2. Retirez tous les bijoux que vous avez sur les mains

Même si cela n'est pas obligatoire, envisagez d'enlever les bracelets, les bagues ou tout autre bijou que vous avez sur vos mains. Ils peuvent contaminer les gants, rendre leur mise en place difficile ou créer un inconfort si vous aviez pu les mettre.

PORT DE GANTS PROPRES ET STÉRILES

OBJECTIF GENERAL

Maîtriser la technique du port de gants propres et stériles.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Quels sont les objectifs du port de gants
2. Citer les différents types de gants
3. Enumérer les indications du port de gants
4. Décrire la technique du port de gants propres et stériles.

I. DÉFINITION

Le port de gant est une précaution standard de contact, utilisé lors de la réalisation des soins présentant un risque infectieux pour le soignant et/ou le patient lors d'un soin aseptique.

II. OBJECTIFS

Le port de gants est préconisé :

Pour protéger le patient :

- contre la flore microbienne d'autres patients ;
- pour éviter les risques de transmissions croisées lors des contacts directs, lors d'isolements septiques.

Pour protéger le personnel :

- contre un risque infectieux (sang liquide biologique, patient infecté) ;
- contre un risque chimique (certains médicaments, etc...) ou contre un risque physique (aiguille...).

III. LES DIFFÉRENTS TYPES DE GANTS

- **Gants d'examen propres** (non stériles) : Ils sont fins, fragiles, imperméables aux virus. Ils sont à usage unique, utilisés pour se protéger et éviter le risque de contamination manuportée (soins de courte durée, actes de laboratoire, actes hôteliers). Ils doivent être jetés après chaque soin.
- **Gants d'intervention stériles** : imperméables aux virus. Ils sont aussi à usage unique, utilisés pour la réalisation de petits actes de soins aseptiques dans les services de soins tels que le sondage urinaire, la pose d'une voie veineuse périphérique... Ils doivent être jetés après chaque soin.
- **Gants de chirurgie stériles** : forme anatomique, étanche aux colorants, imperméables aux virus. Ils sont également à usage unique, réservés aux actes chirurgicaux ou aux techniques invasives telles que cathétérisme central. Ils doivent être jetés après chaque soin.

IV. RÔLE

- Ils établissent une barrière étanche entre le patient et l'opérateur ;
- Barrière bactériologique protégeant à la fois l'un et l'autre ;
- Barrière physique (protection contre les piqûres et coupures).

V. INDICATIONS :

Ils sont réservés :

- aux actes chirurgicaux et aux techniques invasives médicales (pose de drain thoracique, biopsies, ponctions...) ;
- aux techniques invasives infirmières (sondage vésical, réfection de certains pansements, manipulation de chambre implantable...).

VI. TEMPS D'UTILISATION

Les gants stériles doivent être changés régulièrement en cours d'intervention pour respecter à la fois l'asepsie des différents temps opératoires et les risques de micro-trous au bout d'un temps moyen d'utilisation.

Des études ont prouvé que le gant devenait poreux au cours de l'intervention même en l'absence de perforation. Un double gantage est recommandé au bloc opératoire selon le type d'intervention.

VII. COMMENT PORTER DES GANTS STÉRILES ?

Ceux qui travaillent dans le domaine médical doivent porter des gants stériles presque tout le temps et doivent le faire correctement. Les mettre comme il se doit a pour avantage de prévenir la transmission et la contraction de maladies infectieuses, que ce soit au patient ou au prestataire de soins.

Vous pourrez vous assurer de bien les porter en vous lavant les mains et en les faisant glisser à l'intérieur des gants une fois qu'elles seront sèches.

Veiller à ce que les mains soient propres.

1. Prenez des gants dont la taille vous correspond

Pour savoir si les gants que vous avez choisis sont de la bonne taille, vous devez vous assurer qu'ils :

- vous permettent de bouger vos doigts confortablement ;
- ne se frottent pas contre votre peau ;
- ne fassent pas transpirer les mains ;
- ne fatiguent pas les muscles des mains.

2. Retirez tous les bijoux que vous avez sur les mains

Même si cela n'est pas obligatoire, envisagez d'enlever les bracelets, les bagues ou tout autre bijou que vous avez sur vos mains. Ils peuvent contaminer les gants, rendre leur mise en place difficile ou créer un inconfort si vous aviez pu les mettre.

3. Veillez à bien vous laver les mains

Avant même de toucher les gants, vous devrez vous assurer de bien vous laver les mains avec de l'eau savonneuse ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool.

4. Gardez vos mains au-dessus de la taille

Une fois qu'elles seront propres, vous devez éviter de faire en sorte qu'elles se retrouvent en dessous de la taille afin de minimiser le risque de les contaminer.

5. Ouvrez l'emballage des gants stériles

Inspectez-le pour voir s'il est intact. Si vous remarquez des déchirures, une décoloration ou de l'humidité au niveau de l'emballage, veillez à le jeter. Ouvrez l'emballage extérieur en séparant les deux feuillets de l'emballage extérieur en les tirant vers le bas.

N'oubliez pas que les gants stériles ont aussi une date d'expiration. Avant donc d'envisager de les porter, vous devez vous assurer qu'ils ne sont pas périmés.

6. Ouvrez l'emballage intérieur

Une fois qu'il sera à découvert, placez-le sur une surface propre.

7. Prenez le gant que vous mettrez dans la main dominante

Avec la main non dominante (celle que vous n'utilisez pas pour écrire), prenez le gant que vous mettrez sur la main dominante et saisissez le repli du poignet du gant (avec le pouce et les deux premiers doigts) en veillant à ne pas toucher la surface intérieure. En portant d'abord le gant sur la main dominante (celle que vous êtes le plus susceptible d'utiliser), vous allez réduire le risque qu'il se déchire ou soit contaminé.

8. Portez le gant sur la main dominante

Tenez-le de manière à ce que les doigts du gant pointent vers le bas. Après cela, glissez lentement votre main dominante ouverte dans le gant en ayant les doigts écartés. Retenez que votre main dominante ne doit toucher que l'intérieur du gant pour éviter toute contamination.

Ne faites des ajustements qu'après avoir porté les deux gants.

9. Mettez le deuxième gant

Placez les doigts de la main gantée sous le repli extérieur du poignet de l'autre gant pour le soulever. Gardez votre seconde main à plat avec la paume vers le haut lorsque vous insérez vos doigts dans le gant.

10. Ajustez les gants.

Après avoir mis les deux gants, vous pouvez maintenant les ajuster. Passez la main sous le bord relevé de chaque gant pour les tirer ou pour effectuer tout autre ajustement dont vous aurez besoin. Ne mettez pas la main entre la peau et les rebords. Lissez chaque gant sur vos mains.

11. Vérifiez si les gants ne sont pas déchirés

Examinez attentivement chaque main et chaque gant.

NB :

- Si vous touchez accidentellement la peau ou un autre objet pendant la procédure, les gants seront contaminés.
- S'ils sont contaminés de quelque manière que ce soit, assurez-vous de vous laver à nouveau les mains avant d'envisager de porter une autre paire de gants stériles.

TECHNIQUES DE PORT DE GANTS



Ne toucher qu'une partie limitée du gant



Ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main déjà gantée

CPias Bretagne - 10 mars 2020 - V2

CPias
Bretagne

CHAPITRE 2 :

SOINS INFIRMIERS DE BASE

TOILETTE GENERALE DU MALADE

OBJECTIF GENERAL

Connaitre la toilette générale du malade.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Donner les généralités sur la toilette du malade.
2. Donner quelques conseils.
3. Décrire le déroulement du soin.

I. GENERALITES

La toilette est un soin de confort et d'hygiène, qui consiste à apporter un bien-être et plaisir au malade. C'est un soin quotidien que l'agent de santé doit assurer lorsque le patient ne peut le faire lui-même. C'est aussi un moment privilégié de relation et d'observation qu'il ne faut pas négliger. La toilette se fait autant de fois que cela est nécessaire chez le patient qui souille. Pour certains malades les soins sont pris entièrement en charge par le personnel soignant.

Mais le soignant doit savoir évaluer ce que le patient peut faire lui-même et dès que son état le permet, et demander sa participation même si minime soit-elle.

S'il s'agit de la toilette complète ou celle d'un segment, vous devez vous référer aux principes de base concernant : le malade, le matériel, la technique.

1.1. Le malade

- Prévenir le malade ;
- Ménager la pudeur du malade ;
- Mobiliser le malade avec douceur ;
- Agir rapidement pour éviter les risques de fatigue et de refroidissement ;
- S'assurer de la bonne température de la pièce ;
- Bien essuyer le patient ;
- Réinstaller le patient.

1.2. Matériel pour la toilette du malade

Le matériel

Matériel pour le personnel soignant :

- Savon pour se laver les mains avant et après le soin ;
- Une serviette pour s'essuyer les mains ;
- Une tenue de travail propre ;
- Un tablier de protection.

On doit tenir compte :

- Des affaires personnelles que possède le malade ;
- Des possibilités du service ;
- De l'endroit où se déroule le soin (chambre, toilette, douche).

Pour une toilette complète au lit, on aura comme matériel, un chariot de soins préalablement nettoyé sur lequel on dispose le matériel suivant :

- Gant de toilette (un ou deux)- 1 Serviette de toilette ;
- Linge pour changer le malade-Toile cirée pour protéger le lit ;
- Savon liquide ou en morceau -Deux cuvettes d'eau chaude ;
- Une couverture -Le linge pour la réfection de lit ;
- Un couvre-lit selon l'habitude du service- Un rasoir métallique bien désinfecté ;
- Un peigne, une brosse, un miroir si possible ;
- Matériel pour brossage des dents ou pour soins de bouche (verre, dentifrice, brosse) ;
- Une paire de ciseaux ou un coupe-ongle ;
- Un lait de toilette et papier absorbant pour nettoyer éventuellement les selles ;
- Matériel pour prévention d'escarres (selon le protocole du service) ;
- Haricots et sacs poubelle pour les déchets ;
- Pour les femmes, il faut rajouter un bassin de lit (pour la toilette intime).

1.3. Technique

Pour la technique, il faut procéder avec méthode donc agir segment par segment. (Voir salle de démonstration pratique).

II. DEROULEMENT DU SOIN (voir fiche d'apprentissage)

Il n'y a pas de technique particulière pour effectuer la toilette, il faut faire preuve de bon sens et de logique. La toilette se déroule habituellement en six temps.

2.1 Première partie : Toilette du visage, du cou et des oreilles

Pour la toilette du visage et du cou, chez les personnes âgées et/ou démentes, on ne commence jamais la toilette par le visage mais par les zones qu'elles peuvent voir (main, bras). Lors de ce premier temps, on peut proposer un lavage des dents et un rasage ; on peut même l'effectuer avant la toilette du visage.

2.2 Deuxième temps : Thorax, membres supérieurs et abdomen

Ce temps de toilette peut être couplé avec une manucure.

2.3 Troisième temps : Membres inférieurs

2.4 Quatrième temps : Toilette intime

- Mettre des gants à usage unique, elle se fait en respectant toujours la pudeur ;
- Proposer lorsque cela est possible que le patient la prenne en charge seul.
- La toilette intime comprend des temps différents selon qu'on l'effectue sur un homme ou une femme.

NB : lors de la toilette intime, ne jamais faire des mouvements avec le gant de l'anus vers la vulve surtout s'il y a des selles. Changer l'eau des cuvettes.

2.5 Cinquième temps : Toilette du dos et des fesses

Après le lavage du dos et la prévention d'escarre, mettre une paire de gants et procéder au lavage des fesses.

2.6 Sixième temps : Brossage des dents, coiffage et rasage

La toilette générale au lit se termine par un brossage des dents ou soins de bouche, le coiffage des cheveux et le rasage chez les hommes.

On peut aussi commencer la toilette par ces soins pour le brossage des dents :

Après tous ces soins, il faut :

- Réinstaller le malade confortablement dans le lit fait et le recouvrir ;
- Mettre le linge sale dans un sac mais jamais à terre ;
- Nettoyer et ranger le matériel ;
- Se laver les mains ;
- Faire la transmission écrite de toutes observations faites au cours de la toilette dans le cahier de transmission ou oralement au responsable.

III. QUELQUES CONSEILS

- Mettre des barrières en cas de déplacement ;
- Respecter la pudeur du malade tout au long du soin ;
- Recouvrir le malade en cas d'absence ;
- Respecter les règles d'hygiène et d'asepsie ;
- Communiquer avec le patient ;
- Etre discret et avoir le tact.

CONCLUSION

La toilette générale d'un malade est un soin qui se réalise selon une chronologie. Il est important de le respecter pour éviter au malade certains désagréments et des maladies nosocomiales. Elle permet d'établir un lien entre le soignant et le malade.

SOINS DE L'ESCARRE OU ULCERE DE DECUBITUS

OBJECTIF GENERAL

Connaître l'escarre ou ulcère de décubitus

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir l'escarre.
2. Décrire le mécanisme de formation de l'escarre.
3. Enumérer les facteurs favorisants.
4. Donner les signes cliniques.
5. Décrire les soins préventifs et curatifs.
6. Citer les stades de localisation.

RAPPEL - GENERALITES

I. PRE-REQUIS

La peau est composée de trois couches : composition de la peau : l'épiderme, le derme et l'hypoderme.

Les fonctions essentielles de la peau sont :

- La protection de l'organisme contre les agressions ;
- La sécrétion ou l'élimination de la sueur (autres) ;
- La régulation thermique (chaude ou froide) ;
- Et l'absorption des produits (cosmétiques, médicaments).

INTRODUCTION

Dans la vie courante, chaque individu est capable de se mouvoir librement. Lorsqu'une personne est alitée, elle perd cette autonomie. Les tissus de son corps sont comprimés à cause de la position allongée. Cette compression empêche les tissus d'être bien irrigués en sang et en oxygène. Il se forme alors une plaie appelée escarre de décubitus.

L'escarre est une affection connue des vieilles civilisations. Elle constitue un problème dans les services hospitaliers. Sur cinq clients alités ou immobilisés, trois sont exposés aux escarres. L'escarre est un défi permanent pour le professionnel en soins infirmiers hospitaliers.

II. DEFINITION

L'escarre (ulcère) est une lésion consécutive à une nécrose cutanée due à la compression prolongée (au-delà de 1 h 30) entre deux plans durs : peau (os) du client / objet de contact permanent (lits, chaises, plâtre ...).

L'escarre survient au lit, on la nomme escarre de décubitus.

III. MECANISME DE LA FORMATION DES ESCARRES

La compression continue des tissus empêche le sang de circuler et coupe l'approvisionnement des tissus en oxygène (anoxie tissulaire), il s'en suit alors la nécrose des tissus d'où la formation de l'escarre.

IV. FACTEURS FAVORISANT

Plusieurs facteurs de risques entrent en jeu dans la survenue des escarres.

a. L'état général du client

- 1- Immobilité prolongée (opérée, affection cardio-respiratoire, comas).
- 2- Etat nutritionnel (alimentation pauvre).
- 3- L'humidité (transpiration, incontinence urinaire, fécale).
- 4- Infections nosocomiales (hygiène précaire).

b. L'usage des produits inadaptés dans la prévention d'escarre (Poudre associée à l'humidité favorise l'escarre).

c. La méconnaissance du processus de formation des escarres Par les professionnels infirmier ou sage-femme.

V. MALADES MENACES D'ESCARRES

a. Les malades dont la conscience est altérée :

- Comateux ;
- Vieillards ramollis ;
- Sujets cachectiques, amaigris, dénutris.

b. Les malades neurologiques

- Malade paralysée : paraplégie, tétraplégie, hémiplegie ;
- Incontinents par troubles du sphincter (urines, matière fécales).

c. Les malades en chirurgie orthopédique

- Malade porteur d'un appareil plâtré ;
- Opéré du bassin ;
- Traction-suspension par broches.

d. Les grands brûlés

e. Les personnes obèses

f. Les sujets artéritiques ou à nutrition insuffisants des tissus.

- Cardiaque ;
- Œdèmes généralisés ;
- Insuffisants respiratoires ;
- Diabétiques (dont on sait la fragilité cutanée).

VI. SIGNES CLINIQUES

- Le dysfonctionnement des fonctions de la peau ;
- L'érythème cutané ;
- La douleur (en neurologie, la douleur n'est pas évidente) ;
- La chaleur ;
- La fièvre 38° à 40° ;
- L'œdème ;
- La plaie ;
- Les troubles du sommeil (douleur) ;
- La nécrose cutanée ;
- Le mauvais état général.

VII. ZONES DE LOCALISATION OU DE PRESSION DES ESCARRES

Les zones de pression varient selon la position et le poids du client hospitalisé ou immobilisé.

1. La position de décubitus dorsal

- Nuque-occiput, Omoplates, Coudes-fesses, Dos
- Bassin (sacrum), Talon

2. La position de décubitus ventrale

- Front-nez, Poitrine-sein (femme)
- Ventre (abdomen), Organes génitaux (pénis homme)
- Genou, Orteils

3- La position latérale gauche ou droite

- Tête - oreille, Avant-bras, Côtes
- Trochanter, Malléole externe

VIII. STADES D'ÉVOLUTION DES ESCARRES (COMPLICATIONS)

Si la stratégie de prestations de soins préventifs n'est pas appliquée, l'escarre évolue en quatre stades en détruisant les trois couches de la peau.

- **Stade I : Erythème réversible, peau intacte.**
- **Stade II : atteinte partielle de la peau atteignant l'épiderme et/ ou le derme.** La lésion est superficielle et la peau présente à l'examen clinique des lésions telles que : abrasion, phlyctène, cratère superficiel.
- **Stade III : atteinte profonde ou nécrose de la peau atteignant le tissu sous cutané, respect du fascia sous-jacent.** La lésion se présente à l'examen clinique comme un profond cratère avec ou sans atteinte du tissu adjacent.
- **Stade IV : atteinte profonde de la peau avec destruction étendue, tissus nécrosés ou atteinte du muscle, de l'os, ou des structures de soutien** (exemple : tendon, articulation, etc...).

Nous pouvons ainsi dire que quelle que soit la classification utilisée, le personnel soignant doit être capable de reconnaître ces stades de gravité des escarres afin d'effectuer une prise en charge correcte des patients hospitalisés.

IX. SOINS CURATIFS DES ESCARRES

Malgré les précautions, certaines escarres surprennent par leur apparition rapide et insidieuse. L'escarre constituée : Evaluation du stade d'évolution, évaluation de l'état général du client atteint d'escarre afin d'envisager un traitement local et traitement général :

Le traitement général consiste à l'alimentation équilibrée riche en protides et en vitamines, l'hydratation suffisamment importante du malade et la prescription d'antibiotique en cas d'épisodes infectieux.

Le traitement local se fera selon le stade d'évolution :

- En cas de rougeur frictions alcoolisées pratiquées avec douceur et talquer le plus souvent ;
- En cas de phlyctène, percer aseptiquement, panser comme une plaie ;
- Si l'escarre est constituée, éliminer les tissus morts, faire un pansement de la plaie nécrosée au dakin.

Un traitement chirurgical, utilisant toutes les ressources de la chirurgie plastique, peut être envisagé.

Produits utilisés

Dans l'application des soins d'escarre, deux produits sont souvent utilisés ; il s'agit des lubrifiants et du dakin.

Lubrifiants : Beurre de karité, vaseline karité, autres ...

- Protège la peau ;
- Bloque le processus infectieux ;
- Un cicatrisant ;
- Stimule les fonctions de la peau.

Dakin : Extrait de nécrose cutanée

- Bloque le processus infectieux y compris les odeurs.

Rôle et actions des produits utilisés

Produits utilisés	Effets / rôle des produits
Eau / savon	- hygiène de la peau - bactériostatique - intégrité / surface cutanée - énergie des fonctions de la peau
Dakin Le pansement américain ou le plumasseau 24 h à 48 h / durée	- bactéricide - extrait les tissus nécrosés - régénération des tissus - éliminé les odeurs - cicatrisant - sécurité du milieu des soins
Lubrifiants - beurre de karité - vaseline karité - crèmes / lotions - autres	- hydrate la peau - protection de tissu cutané - tonifie la peau - hygiène générale de la peau - intégrité de la peau - supprime la compression - antiseptique - anti-inflammatoire - élimine les infections nosocomiales

X. SOINS PREVENTIFS DES ESCARRES (voir fiche d'apprentissage)

Il s'agit de la combinaison harmonieuse de différentes techniques de soins :

- L'hygiène corporelle et propreté (toilette générale) ;
- La friction ou le massage avec un lubrifiant : le beurre de karité ;
- Le traitement (maladie / motifs d'alitement).
- L'IEC sur le concept escarre et les signes cliniques combiné aux soins d'hygiène et de propreté :
 - Tenir le malade au sec ;
 - Eviter les plis des draps et les miettes de pain ;
 - Prendre des précautions à la pose du bassin.
- Le changement de position toutes les 2 heures d'alitement prolongé,
- Utilisation du matelas alternating

C'est le moyen le plus moderne et efficace dans la prévention de l'escarre, chez tous les clients alités et immobilisés dans les services hospitaliers. Mais ce matelas n'est malheureusement pas disponible dans tous les services.

Le matelas alternating est constitué par des tubes de caoutchouc remplis d'air, qui sont gonflés et dégonflés alternativement grâce à un compresseur, il change automatiquement les points de pression.

- Massage et friction avec un lubrifiant ; beurre de karité
- Stimulant de la peau ;
- Antimicrobien ;
- Tonique fonction de la peau ;
- Cicatrisant.

CONCLUSION

Le rôle de l'infirmier et de la sage-femme est primordial dans la prévention des escarres. On a pu dire que l'existence d'escarres dans un service est un mauvais point pour le personnel soignant.

La prévention d'escarres doit être systématique chez tout pour lequel on le redoute.

Toute occasion est bonne pour faire un massage des régions menacées. Il suffit d'avoir une fois constaté l'évolution fulgurante de l'escarre, sa guérison très lente pour comprendre l'importance de la prévention et le rôle de l'infirmier et de la sage-femme en particulier et le personnel en général.

SOINS D'HYGIENE DES CAVITES NATURELLES

OBJECTIF GENERAL

Faire les soins des cavités naturelles.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Citer les indications des soins des yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la gorge
2. Enumérer le matériel utilisé
3. Laver les différentes cavités
4. Appliquer l'instillation de collyre ou autre solution

INTRODUCTION

Les soins des cavités naturelles sont les soins de propreté qui se font tous les jours après la toilette générale.

I. SOINS DES YEUX

1.1. Indications

Le nettoyage des yeux est un soin qui se fait dans l'inflammation de la paupière, de la conjonctivite et dans le traumatisme crânio-facial.

1.2. Matériel

- Boules de coton stérile propre
- Eau bouillie tiède ou sérum physiologique
- Alcool 90°, Haricot, Godet

1.3. Technique (voir fiche d'apprentissage)

II. LE LAVAGE DES YEUX

Indication :

Le lavage des yeux est indiqué dans les conjonctivites purulentes et dans l'élimination d'un corps étranger dans l'œil.

Technique (voir fiche d'apprentissage)

N.B : Il est parfois nécessaire d'installer dans l'œil une goutte de collyre ou mettre une pommade ophtalmique.

III. INSTILLATION DE COLLYRE

Le collyre est une préparation médicamenteuse.

- a. Indication : Elle est indiquée dans les affections des yeux, dans les allergies (antiseptiques).
- b. Matériel : Collyre, Boules de coton ou compresse
- c. Technique (voir fiche d'apprentissage)

IV. SOINS DU NEZ

4.1. Indication

Il est indiqué dans les affections du nez et dans la présence de corps étranger dans les narines.

4.2. Matériel

- Tige montée de coton ;
- Sérum physiologique ou l'eau bouillie tiède ;
- Solution prescrite ;
- Boule de coton ou une compresse ;
- Un haricot.

4.3. Technique (voir fiche d'apprentissage)

V. SOINS DES OREILLES

5.1. Nettoyage

Indication :

Ce soin a pour but de dégager les conduits du cérumen (liquide sécrété dans l'oreille).

Matériel

- Tiges porte cotons propres ou stériles ;
- Boule de coton solution médicamenteuse ;
- Alcool, haricot ;
- Plateau stérile.

Technique (voir fiche technique)

5.2. Lavage d'oreille

Indication :

Il consiste à irriguer le conduit auditif pour éliminer les corps étrangers lors d'une suppuration importante.

Matériel

- Poire à oreille ;
- Bock (gobelet avec tuyau) ;
- Une alèze, haricot.

Technique (voir fiche d'apprentissage)

Il peut y avoir des incidents comme les nausées et vertige (solution trop chaude ou froide).

VI. LES SOINS DE LA BOUCHE

C'est un soin qui a pour but de maintenir les caractères physiologiques de la cavité buccale, l'humidité, l'alcalinité, absence de germes pathogènes, une bonne halène.

Indication :

Il est indiqué chez les malades ne s'alimentant pas par la bouche, et ceux éliminant les produits toxiques par la bouche, les malades fiévreux, ceux au régime lacté et les comateux.

Matériel

- Solution alcaline (l'eau bicarbonatée) ;
- Collutoire ou solution antiseptique ;
- Compresse ou coton ;
- Pince de Kocher ou tige ;
- Verres, Serviette, Haricot ;
- Une brosse à dent et une pâte dentifrice.

Technique (voir fiche d'apprentissage)

• Les soins de la gorge

Les soins de gorge sont prescrits le plus souvent en O.R.L. Ils consistent à faire le gargarisme. Le badigeonnage et la pulvérisation de certains produits. Les soins des orifices sont des activités souvent négligées par le personnel infirmier et sage-femme.

Il est donc impératif qu'un accent soit mis sur ces soins afin de permettre aux malades de satisfaire à tous les besoins fondamentaux selon le modèle conceptuel de Virginia Henderson en évitant des infections de ces cavités dont le diagnostic est quelquefois difficile à faire.

L'exécution de tels soins permet au professionnel de rentrer dans l'intimité du malade et faire ainsi preuve d'empathie.

INSTALLATION ET DIVERSES POSITIONS DU MALADE DANS LE LIT

OBJECTIF GENERAL

Connaitre l'installation et diverses positions du malade dans un lit.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Déterminer les conséquences d'une position défectueuse.
2. Appliquer le changement de positions des grands malades.
3. Décrire les positions de confort du malade dans le lit.
4. Enumérer les indications.
5. Citer le matériel.
6. Décrire les différentes techniques.
7. Expliquer le rôle de l'infirmier et de la sage-femme.

INTRODUCTION

Les différentes postures ou positions de confort du malade dans le lit, lui permettent de se reposer selon son état de santé. Il est donc important de connaître certains principes de positions pour les adapter à l'état des malades et éviter ainsi les positions vicieuses ou inconfortables.

CONSEQUENCES D'UNE POSITION DEFECTUEUSE

Une position défectueuse peut être cause :

- D'une raideur des muscles et des articulations ;
- Des crampes extrêmement douloureuses ;
- Des escarres ;
- Des troubles respiratoires et circulatoires ;
- Des déformations diverses : cyphose, affaissement de l'articulation du genou.

I. ROLE DE L'INFIRMIER OU DE LA SAGE-FEMME

Le rôle de l'infirmier consiste à donner au malade une position confortable et de détente. La meilleure position physiologique de repos est celle dans laquelle tous les muscles sont moyennement relâchés : jambes légèrement relevées, genoux fléchis, bras légèrement pliés au coude, coude en antéflexion. Cette position s'obtient dans le décubitus latéral et dorsal.

- Arranger les oreillers (chez tous les malades, 2 fois par jour et chez les malades immobilisés, plusieurs fois par jour) ;
- Redresser le malade (plier les jambes, s'appuyer sur le talon, fléchir la tête).

II. DIFFÉRENTES POSITIONS DE CONFORT DU MALADE DANS LE LIT,

Unité pédagogique SOINS INFIRMIERS - Année académique 2025-2026 - Licence 1 IDE/SFM

2.1. Décubitus dorsal

• Position dorsale ordinaire

Indication : Sujet âgé (55 – 65 ans)

Les personnes âgées respirent mieux dans cette position.

Technique : Il est installé en position dorsale, tête et épaules relevées par un traversin et deux ou trois oreillers selon le cas.

• Position dorsale allongée

Indications : Examens du thorax, de l'abdomen, des membres

- Position de repos, Sondages

Technique : Le malade est étendu à plat sur le dos, un oreiller ou non sous la tête ; la plante des pieds repose sur le lit ou les jambes, les pieds sont maintenus droits.

NB : Cette position est interdite pour les personnes inconscientes.

2.2. Décubitus latéral gauche et droit :

Cette position est très reposante

Indication : Malades inconscients

Technique : On tourne le malade sur le côté, un oreiller sous la tête. Il est appuyé sur l'épaule et le bras ;

- La jambe placée contre le plan du lit est détendue ;
- L'autre jambe est repliée sur le plan du lit devant la précédente ;
- On place un coussin contre l'abdomen ; le dos s'appuie contre un autre coussin ;
- On change régulièrement de côté si possible, car la compression prolongée fait courir le risque d'escarre.

2.3. Décubitus ventral

Indications : Occlusions - Opérés du rachis

- Opérés du rectum - Changement de position

- Sujets inconscients (ce qui permet le rejet plus facile des vomissements)

Technique : le malade est couché sur le ventre, la tête sur le côté sans traversin

- On dispose un oreiller plat au niveau de la poitrine.

2.4. Position semi-assise ou position de Fowler

Indications : Dyspnée - Opérés de l'abdomen, de l'estomac - Suppurations abdominales

- Asthmatiques - Complications pulmonaires
- Chez certains cardiaques - Chez les vieillards

Contre-indication : Hypotension, Après anesthésie



Technique : Le malade est en décubitus dorsal sur une table gynécologique

- Les jambes sont fléchies en abduction ou maintenues dans les jambières.
- Intervention chirurgicale sur l'anus et le rectum (exemple : Hémorroïdes)

Indications : Toucher vaginal - Sondage vésical chez la femme

2.7. Position gynécologique

Technique : Dans cette position, la tête du malade se trouve plus haute que les jambes. Le malade est couché ou demi-assis selon son état.

Cette position est le contraire de la position déclive ou Trendelenburg.

Indication : Hypotension artérielle

2.6. Position proclive

- Surélever les pieds du lit par des cales ou une chaise à la hauteur indiquée par le médecin (il faut des cales assez hautes)
- Mettre un deuxième oreiller vertical contre les barreaux du lit, pour empêcher le malade de se heurter la tête contre le lit.

Technique : Dans cette position, la tête du malade se trouve plus basse que les

But : Irriguer le bulbe rachidien pour prévenir la syncope.

- Menace d'Accouchement Précoce (état de choc) ;
- Hypotension (état de choc) ;
- Après certaines rachi anesthésies ;

Indication : Après ponction lombaire

2.5. Position de Trendelenburg (ou déclive)

- Mettre le cadre du lit à l'inclinaison voulue ;
- Placer trois oreillers de façon que le malade puisse bien s'appuyer contre le cadre du lit ;
- Bien installer le malade ;
- Eventuellement, mettre un oreiller sous les genoux pour le confort du malade ;
- Mettre une cale aux pieds du malade pour l'empêcher de glisser.

Technique : Bien tirer le drap de dessous

- Relâcher les muscles abdominaux.
- Permettre d'éviter les complications pulmonaires ;
- Favoriser la collection et le drainage des liquides ;

Buts : Faciliter la respiration, la circulation

Unité pédagogique SOINS INFIRMIERS - Année académique 2025-2026 - Licence 1 IDE/SFM

2.8. Position Genou- pectorale**Indications : Rectoscopie -Toucher rectal**

- Intervention chirurgicale sur l'anus et le rectum

Technique : La malade est agenouillée sur le lit, les fesses proéminentes, les cuisses verticales

- Le haut du thorax repose sur le lit ;
- Les bras sont repliés par côté ;
- Les genoux touchent les coudes ;
- La tête est tournée sur le côté.

III. MATERIEL

- Des traversins ;
- Des coussin ou oreillers ;
- Des cales ou chaises.

IV. CHANGEMENT DE POSITION DES GRANDS MALADES

Tout malade incapable de se mouvoir ne doit pas rester plus de trois (03) heures dans la même position, sinon risque d'escarres.

On peut dans ce cas, établir un tableau de changement de position.

Tableau de changement de position des grands malades

Heures	Position	Signature de la personne responsable
08 H	D	
11 H	LD	
14 H	V	
17 H	LG	
20 H	D	
23 H	LD	
02 H	D	
05 H	LG	

D : position Dorsale

V : position Ventrale

LD : position Latérale Droite

LG : position Latérale Gauche

CONCLUSION

L'importance des soins relatifs à la position des malades exige du personnel soignant, une attention particulière et une connaissance parfaite des positions de confort selon le cas en présence.

CHAPITRE 3 :
**TECHNIQUES DE SOINS
INFIRMIERS DE BASE EN
MEDECINE ET EN CHIRURGIE**

SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION DE THERMOREGULATION

THERMOREGULATION

OBJECTIF GENERAL

Comprendre la thermorégulation.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir la thermorégulation.
2. Déterminer les éléments de lutte contre le froid/la chaleur.
3. Définir l'homéothermie.

I. DEFINITION

C'est un équilibre précis entre les mécanismes chimiques producteurs de chaleur et les phénomènes physiques la dissipant.

Le réglage est fait par le centre nerveux thermorégulateur situé dans le diencéphale, et par le contrôle endocrinien du métabolisme qui est sous la dépendance de la thyroïde.

II. LUTTE CONTRE LE FROID.

Elle s'effectue :

- Par augmentation de la production de chaleur (thermogénèse). C'est une augmentation générale du métabolisme cellulaire et la mise en jeu des muscles du squelette, aboutissant au frisson qui augmente les combustions.
- Par une réduction des pertes : absence de sudation et vasoconstriction cutanée (diminution du calibre des artères et des veines par contraction de leurs fibres musculaires lisses).

III. LUTTE CONTRE LA CHALEUR

Elle s'effectue par la thermolyse qui est une déperdition de chaleur. C'est presque exclusivement une augmentation des pertes : sudation et vasodilatation avec une réduction métabolique faible.

IV. L'HOMÉOTHERMIE

C'est le résultat de la thermorégulation.

On dit que l'homme est homéotherme parce qu'il a la faculté de maintenir sa température constante et de s'adapter aux contraintes climatiques.

V. LES CENTRES DE LA THERMOREGULATION

Ces centres sont sous la dépendance du système nerveux central :

- La moelle épinière : conductrice sensitive qui permet la sudation réflexe ;
- L'hypothalamus qui régule la température corporelle. Il contrôle l'activité des glandes (hypophyse, thyroïde, surrénales).

VI. LA MISE EN JEU DES CENTRES DE LA THERMOREGULATION

Des thermorécepteurs vont évaluer la température centrale et envoyer leurs informations à l'hypothalamus. Il existe deux types de thermorécepteurs :

- **Thermorécepteurs profonds** : sensibles à la température qui les baigne. Ils envoient l'information par voie sanguine à :
 - L'hypothalamus ;
 - La moelle épinière ;
 - Les viscères abdominaux.
- **Thermorécepteurs superficiels** : situés au niveau de la peau. Ils envoient l'information par voie nerveuse (la voie de KRAUSS pour le froid, ou le chaud).

VII. LE METABOLISME BASAL

Le métabolisme basal est la production de chaleur du corps humain par heure et par mètre carré de la surface corporelle lorsque le sujet est au repos ou à une neutralité thermique.

Le métabolisme basal dépend de la taille, du poids, du sexe, de l'âge

VIII. LA THERMOGENESE

C'est la production de chaleur par l'organisme pour maintenir constante la température interne. La thermogénèse est réalisée par :

- L'oxydation des réserves de protéines ;
- Les contractures musculaires ;
- Le foie ;
- Les hormones.

IX. LA THERMOLYSE

C'est la déperdition de chaleur par l'organisme pour maintenir constante la température interne. Elle est réalisée par :

- La radiation : transport de la chaleur sous forme d'infrarouge d'un objet plus chaud à un objet plus froid sans contact.
- La conduction : transmission de la chaleur d'un corps à un autre par contact.
- La convection : transfert de la chaleur par un corps en mouvement.
- L'évaporation : conversion d'un liquide en vapeur (sudation, respiration).

TEMPERATURE CORPORELLE ET LE THERMOMETRE MEDICAL

OBJECTIF GENERAL

Connaitre la température corporelle et le thermomètre médical.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir la température corporelle.
2. Définir le thermomètre médical.
3. Décrire le thermomètre médical.

I. LA TEMPERATURE

1. Définition

La température corporelle est la quantité de chaleur stockée par l'organisme humain. Elle est sous le contrôle de l'hypothalamus et dépend de la température sanguine et cutanée. La température normale est de 36,5 le matin et de 37,5 le soir.

2. Variation de la température

La température subit de légères variations de demi à un degré Celsius par 24 H.

- **Variations physiologiques.** La température varie avec :
 - L'activité physique ;
 - L'âge, le sexe, le climat ;
 - Les régions anatomiques (température périphérique plus que la T°. interne).
- **Variations pathologiques.** Au-delà d'un certain seuil, la température corporelle devient soit : Hyperthermique : température supérieure à la normale
 - Hypothermie : température inférieure à la normale.

II. LE THERMOMETRE MEDICAL

La température se prend à l'aide d'un thermomètre gradué à 1/10 de degré, basé sous la dilatation de mercure. Il est composé d'un réservoir contenant le mercure et d'une tige fixée devant une échelle graduée en degré Celsius de 35 à 41.

L'étranglement supérieur du réservoir empêche la redescente du mercure dilaté.

- **Différentes sortes de thermomètres :**
 - Le thermomètre buccal ;
 - Le thermomètre rectal ;
 - Le thermomètre papier test frontal ;
 - Le thermomètre électronique.

• Les endroits de la prise de température :

- Prise de la température rectale (au niveau du rectum) durée 3 mn ;
- Prise de la température buccale (sous la langue) durée 10 mn ;
- Prise de la température axillaire (sous les aisselles) durée 10 mn.

• Différentes courbes de température :

- Courbe en plateau, Courbe intermittente, Courbe inversée, Courbe en lysis
- Courbe ascendante, Courbe ondulante

FEUILLE DE TEMPERATURE

OBJECTIF GENERAL

A la fin du cours l'étudiant de la Licence 1 doit connaître la feuille de température.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir selon le cours une feuille de température.
2. Décrire en ses propres termes une feuille de température sans en altérer le sens.
3. Reconnaître les différentes courbes sur une feuille de température.

I. DEFINITION

La feuille de température est un document de soins infirmiers conçu par l'infirmier comportant un ensemble de renseignements ou d'informations relatifs au malade pour suivre avec précision, les signes vitaux du patient et surveiller l'évolution de son état de santé.

II. DIFFERENTES PARTIES DE LA FEUILLE DE TEMPERATURE :

La feuille de température peut être divisée en 5 (cinq) parties :

- La partie administrative ou l'on identifie le malade ;
- La partie du traitement ou l'on mentionne les différents médicaments administrés au patient durant son séjour dans le service ;
- La partie bilan ou l'on inscrit tous les examens demandés au malade ;
- La partie des paramètres ou sont dessinées tous les graphiques après la mesure des signes vitaux ;
- La partie de la surveillance des entrants ou des pertes.

III. COMMENT REMPLIR LA FEUILLE DE TEMPERATURE ?

A- Partie administrative : Noter tous les renseignements du patient dès son admission dans la salle d'hospitalisation.

B- Partie traitement : Transcrire le protocole de traitement prescrit par le médecin par ordre d'importance (voie parentérale jusqu'à la voie locale)

C- Noter la date de rentrée du patient dans le service en rouge puis les autres jours en bleu.

D- Noter tous les examens demandés dans la partie bilan.

E- Tracer les graphiques de chaque paramètre après les avoir mesuré.

F- Noter les pertes et le poids du patient dans la partie surveillance.

IV. CARACTERISTIQUES DES CONSTANTES SUR LA FEUILLE DE TEMPERATURE

- La température est de 2 à 2/10 de degré représentée par une courbe bleue
- Le pouls est 3 à 3 pulsations, représenté par une courbe rouge ;
- La tension artérielle est de 1 à 1 mm Hg représentée par un histogramme hachuré rouge ;
- La respiration est de 1 mouvement respiratoire à 1 mouvement respiratoire et représentée par une courbe verte ;
- Les urines : la diurèse est de 100 à 100 ml représentées par un histogramme coloré en jaune.

En cas d'intervention chirurgicale, la date est indiquée par une flèche en rouge. On indiquera également par une flèche l'ablation de drain et de fils

VESSIE DE GLACE

OBJECTIF GENERAL

Connaître la vessie de glace.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir une feuille de température.
2. Décrire les différentes parties de la feuille de température.
3. Remplir la feuille de température.
4. Déterminer les caractéristiques des constantes.

I. DEFINITION

C'est une poche de caoutchouc ronde munie d'un bouchon hermétique. Elle a un but thérapeutique.

II. PROPRIETES DE VESSIE DE GLACE

- Localise l'infection - Décongestionne - Calme la douleur ;
- Ralentie le péristaltisme - Baisse la température ;
- Préviend ou arrête certaines hémorragies.

III. INDICATIONS :

- **Médicales** : - Hémorragie interne - Hémorragie cérébrale - Méningite - Cholécystite aigue - Fièvre typhoïde.
- **Chirurgicales** : - Péritonite - Appendicite - Fracture du crâne.
- **Obstétricales** : - Salpingite - Grossesse extra utérine - Abscess du sein.

IV. CONTRE-INDICATIONS

Grossesse normale - Constipation.

V. MATERIEL

Cuvette d'eau - Vessie de glace - Housse de flanelle ou de gaze
Cerceau de soutien ou alèze - Du talc - De la glace - Bande de corps.

VI. PREPARATION DE LA VESSIE

- Remplir la vessie au 2/3 de glaçons ronds ;
- Chasser l'air en appuyant sur la poche ;
- Fermer hermétiquement - Vérifier l'étanchéité de la vessie ;
- L'envelopper de coton cardé - Vaseliner la partie intéressée- Poser la vessie.

VII. POINTS D'APPLICATION DE LA VESSIE DE GLACE

- D'abord, protéger la peau avec un linge ou de la crème ;
- Sur la tête : hyperthermie ou céphalée ;
- Sur l'abdomen : appendicite ou salpingite ;
- Racines des membres supérieurs et les cuisses.

VIII. SURVEILLANCE

- Prise de la température qui doit être normale ;
- Renouveler la vessie toutes les 2h ;
- Surveiller la peau car risque de gelure ;
- Le linge de protection doit être épais.

NB :

Il ne faut jamais poser la vessie de glace au niveau des poumons pour éviter les bronchites.

BOUILLLOTTE

OBJECTIF GENERAL

Connaitre la vessie de glace.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir la vessie de glace
2. Citer les propriétés d'une vessie de glace
3. Donner les indications et contre-indications d'une vessie de glace
4. Enumérer le matériel pour la pose d'une vessie de glace
5. Identifier les points d'application d'une vessie de glace
6. Appliquer la surveillance.

I. DEFINITION

C'est une poche en caoutchouc avec un bouton contenant de l'eau chaude (70 degré). C'est l'un des soins de correction hypothermique.

II. INDICATIONS

Refroidissement, frisson, état de choc.

III. PROPRIETES DE LA BOUILLLOTTE

Elle permet de :

- Réchauffer le lit d'un opéré ;
- Réchauffer le berceau d'un prématuré ;
- Activer la circulation sanguine ;
- Calmer la douleur ;
- Garder un pansement chaud ;
- Faire transpirer le malade.

IV. CONTRE-INDICATIONS

- Œdème - Nouveau-né - Allergie à la chaleur ;
- Paraplégique - Comateux.

V. MATERIEL

- Bouillotte - Cuvette d'eau chaude ;
- Coton cardé -Housse de gaze ou une serviette.

VI. PREPARATION :

- Verser de l'eau chaude au 2/3 dans la bouillotte ;
- Chasser l'air restant ;
- Fermer et vérifier l'étanchéité ;
- L'envelopper de coton cardé ;
- Recouvrir de housse de gaze ;
- Poser la bouillotte à 10 cm du pied du malade.

VII. SURVEILLANCE

- Changer l'eau toutes les 2h
- Vérifier la réaction du malade (disparition des frissons)
- Prendre la température qui doit être normale

La surveillance doit être rigoureuse chez les enfants, les agités, les comateux.

COUP DE CHALEUR

OBJECTIF GENERAL

Connaitre le coup de chaleur.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir le coup de chaleur.
2. Citer les étiologies du coup de chaleur.
3. Identifier les manifestations cliniques.

I. DEFINITION

C'est un accident grave, brutal, provoqué par l'exposition prolongée à la chaleur. Ce qui entraîne des perturbations de la thermorégulation.

II. ETIOLOGIES

- Local surchauffé ou mal adapté au climat
- Temps chaud
- Travail trop près d'un four
- Habillement lourd, non adapté
- Bébé enfermé dans une pièce ou une voiture exposée au soleil
- Bébé trop couvert alors qu'il n'a pas froid.

III. MANIFESTATIONS CLINIQUES

- **Début brutal :**
 - Céphalées, vomissements, vertiges, troubles du comportement ;
 - Coma ;
 - Hyperthermie entraînant la cyanose.

- **Période d'état :**

- Tachycardie ;
- Polypnée ;
- Baisse de la TA ;
- Température à 40 degré ;
- Enfant mou, somnolent ou inconscient ;

- **Evolution :**

- Mort dans 70 /100 des cas ;
- Séquelles neurologiques chez le survivant ;

- **Traitement :**

C'est une urgence qui consiste à :

- Soustraire la victime de la chaleur
- Faire boire le malade
- Chez le bébé faire boire de l'eau sucré ou salée
- Faire descendre la température.

INSOLATION

OBJECTIF GENERAL

Reconnaitre l'insolation.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir l'insolation.
2. Identifier les manifestations cliniques.
3. Donner la conduite à tenir face à l'insolation.
4. Proposer le traitement.

I. DEFINITION

C'est un coup de chaleur dû à l'exposition directe et prolongée au soleil.

II. MANIFESTATIONS CLINIQUES

- Déshydratation accompagnée de signes neurologiques (céphalées non calmées par l'aspirine) ;
- Agitation ou convulsion chez l'enfant ;
- Hyperthermie.

III. CONDUITE A TENIR

- Soustraire la victime du soleil ;
- L'allonger dans un endroit frais en position latérale pour éviter la chute en arrière de la langue et l'encombrement de gorge par les mucosités ;
- Vérifier la respiration ;
- Faire une ventilation ;
- Envelopper la tête de compresses froides ;
- Hospitaliser le malade.

IV. TRAITEMENT

Perfusion IV de sérum glucosé iso +k+Ca+Na

V. ACTION EDUCATIVE

- Non exposition des enfants trop longtemps au soleil ;
- Baigner les enfants quand il fait chaud ;
- Leur donner à boire très souvent ;
- Protéger la tête chauve au chapeau.

SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION LOCOMOTRICE**PREPARATION DU CHARIOT DE SOINS****OBJECTIF GENERAL**

Appliquer la technique de la préparation du chariot de soins.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Déterminer le rôle du chariot de soins.
2. Enumérer les différents types de chariots de soins.
3. Expliquer la préparation du chariot de soins.
4. Décrire l'organisation des différents types de chariots de soins.

DEFINITION : LE CHARIOT A PANSEMENT

Le chariot à pansement est un engin métallique à quatre roues comportant 3 niveaux maximum destiné à transporter le matériel de pansement jusqu'au lit du malade.

On dispose le matériel stérile sur l'étage supérieur, le matériel propre sur l'étage moyen et tout le matériel septique (haricot et poubelle) sur l'étage inférieur.

S'il s'agit d'un chariot à deux étages, disposer le matériel et le matériel propre sur l'étage supérieur et le matériel septique sur l'étage inférieur.

A/ LE CHARIOT A DEUX ETAGES**I. OBJECTIF**

Permettre à l'IDE de préparer le matériel nécessaire à la réalisation des soins.

II. PRESENTATION

Il existe plusieurs modèles de chariot de soins. Tous ont un étage supérieur et un étage inférieur. On pourra trouver sur certain chariot, un étage intermédiaire. L'infirmier s'en servira peu sauf, par exemple, lors de la préparation d'un chariot des soins pour la réfection d'un pansement.

III. ROLE

Le chariot de soins permet de rassembler dans un espace judicieusement conçu et restreint un matériel d'usage courant.

- Il ménage un espace libre pour permettre les nombreuses manipulations aseptiques ou non que requièrent les soins.
- Il s'oppose par son organisation et l'usage qui en est fait, à la dispersion microbienne, et donc à la contamination.
- Il concourt à une pratique rationnelle : économie de gestes, de temps, de fatigue.

IV. ORGANISATION DU CHARIOT

- Le chariot est préparé en salle de soins ;
- Désinfecté le chariot avant de le préparer pour les soins.
- 1. **A l'étage supérieur** : matériel stérile et propre, linge (alèses, draps, ...), désinfectant.
- 2. **A l'étage inférieur** : haricot, sacs poubelles, bac de décontamination pour les instruments (en cas de pansement), sac pour récupérer le linge sale
- 3. **A la fin des soins** : Désinfection, lavage, décontamination de tout le matériel du chariot
- Désinfection entière du chariot, le chariot doit être rapidement utilisable ;
- Ne pas laisser de matériel dessus.

NB : Eviter de stocker les flacons réutilisables de la salle de soin pour les raisons suivantes :

- Aucune connaissance sans de péremptions de produit.
- Les flacons sont sources d'infections nosocomiales ;
- Préférer le matériel à usage unique ;
- L'équipe soignante est souvent jugée à la tenue de son chariot de soins.

B/ LE CHARIOT DE PANSEMENT A TROIS ETAGES**I. COMMENT ORGANISER MON CHARIOT DE SOINS ?**❖ **1^{er} plateau : le haut**

- **Matériel stérile** : L'étage supérieur doit rester le plus libre possible pour permettre les manipulations aseptiques. Lieu d'entreposage des produits aseptiques : de plus en plus de conditionnements unidosés. On jette les produits après chaque série de pansements. Tiroir ou tablettes permettent de stocker du petit matériel en laissant libre le plateau supérieur.

❖ **2^{ème} plateau : le milieu (étage moyen)**

Il sert à déposer **tout ce qui est propre** : Matériel de contention et de protection. Lingette et détergent désinfectant.

❖ **3^{ème} plateau : le bas (étage inférieur)**

On y entrepose **le matériel sale** : Boîte à aiguilles, haricot, poubelle, le linge sale.

II. CLASSER LES ELEMENTS DANS LE CHARIOT DE SOINS

1. **Préparation du chariot de pansement** : Le chariot est nettoyé et désinfecté.
2. **Etages du chariot de pansement** : Le matériel est disposé sur le chariot en respectant les trois étages du chariot.
 - 2.1. **Premier étage**
 - **Le matériel stérile** : Boîte d'instrument, plateau, tambour, pince à servir
 - **Produits utilisés** : Sérum physiologique, antiseptiques.

2.2. Deuxième étage

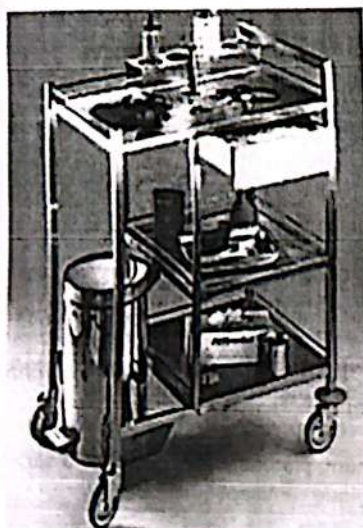
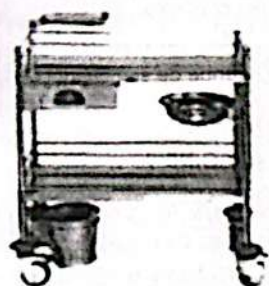
- Contient le matériel de contention : Bande, sparadrap, coton ;
- Matériel de protection : Alèse, gants à usage unique, les produits médicamenteux : pommades, poudre.

2.3. Troisième étage

- Contient le matériel septique :
 - o 1 haricot pour le recueil des compresses souillées ;
 - o 1 autre haricot contenant un bain de pré désinfection pour le recueil de matériel souillé. Ceci pour éviter la contamination aéroportée.

NB : Pour tous les actes de l'infirmier, le chariot de soins doit rester dans le couloir. L'infirmier a la responsabilité de nettoyer le chariot entre chaque service.

LES CHARIOTS A DEUX ET TROIS ETAGES



PANSEMENTS

OBJECTIF GENERAL

Connaitre le pansement.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir un pansement.
2. Citer le matériel.
3. Citer les différents types de pansement.
4. Déterminer le but d'un pansement.

INTRODUCTION

Le pansement constitue l'un des soins infirmiers d'une grande importance. Sa mauvaise conduite peut entraîner des infections responsables des complications très grave (la septicémie, le tétanos...) qui mettent en jeu le pronostic vital du malade.

C'est pourquoi, il est important pour le personnel soignant d'avoir des connaissances et des habiletés pour exécuter ce soin.

I. DEFINITIONS

Le pansement est un dispositif de protection destiné à recouvrir une plaie, une lésion au moyen de compresse stérile. Il est fixé soit par un bandage soit par un adhésif. Le pansement peut aussi être défini comme un ensemble d'actes assurant le traitement d'une plaie, d'une contusion ou d'un abcès.

II. BUTS

Le pansement a quatre buts essentiels :

2.1 Buts de protection

Il protège la plaie contre toute contamination, infection et irritation.

2.2 Buts de désinfection

Il vise à détruire les germes pathogènes et saprophytes et à permettre une meilleure cicatrisation de la plaie.

2.3 But de compression

Il vise à arrêter une hémorragie ou limiter un épanchement en comprimant les vaisseaux sanguins.

2.4 But d'absorption

Il favorise la guérison par l'absorption des écoulements et le débridement de la plaie.

III. DIFFERENTS TYPES DE PANSEMENT

Il existe plusieurs types de pansements.

3.1 Les pansements secs

3.1.1 Le pansement sec aseptique (exempt de germe)

C'est un pansement protecteur et qui s'applique sur une plaie aseptique. Exemple : plaie opératoire aseptique traumatisme non infecté. Il requiert une aseptie rigoureuse.

3.1.2 Le pansement sec antiseptique

C'est un pansement désinfectant qui a pour but de prévenir l'infection. Par exemple : suture périnéale.

3.2 Les pansements humides

3.2.1 Le pansement humide froid

Le pansement humide froid est indiqué dans les œdèmes et contusions. Il peut être renouvelé trois fois par jour.

3.2.2 Le pansement humide chaud

Le pansement humide chaud est un pansement qui se fait en cas d'hématome et d'abcès chaud. Il se fait avec du matériel stérile et le pansement est renouvelé trois fois par jour.

3.2.3 Le pansement humide alcoolisé

Il est indiqué dans le début de panaris et dans les lymphangites et se fait en mouillant la compresse avec l'alcool à 90°. Il est souvent renouvelé dans la journée.

3.2.4 Le pansement avec drain ou mèche

Il se fait après incision d'une collection purulente pour assurer l'écoulement du pus.

3.2.5 Le pansement absorbant

Il est indiqué dans les plaies suppurées.

Dans ce cas, on fait le plumasseau ou pansement américain qui consiste à mettre sur la plaie une couche de coton hydrophile et une couche de coton cardé, le tout emballé de gaze pour une absorption de sérosité.

3.3 Autres pansements

3.3.1 Pansement avec retrait d'agrafes

Faire le pansement comme un pansement ordinaire. Les agrafes doivent être retirées le 6^{ème} ou 8^{ème} jour suivant l'intervention. Il est bon de retirer une sur deux dans un 1^{er} temps vers le 4^{ème}, 6^{ème} jour et l'ablation totale intervient au 8^{ème} jour.

3.3.2 Le pansement avec retrait de fils

Il faut bien aseptiser les points de suture avant de les retirer. Avec la pince de Kocher, saisir le nœud et dégager le fil à sa base. Dans un 1^{er} temps, on retire 1 sur 2 au 7^{ème} jour et à partir du 10^{ème} jour intervient l'ablation totale.

3.3.3 Le pansement compressif

Il est indiqué dans les plaies ouvertes avec hémorragie externe.

3.3.4 Le pansement au tulle gras

Le pansement au tulle gras est très utilisé dans le traitement des brûlures ou à la suite d'une greffe épidermique.

IV. MATERIEL

Le matériel de pansement est composé comme suit :

4.1 Matériel spécifique

- Boîtes à instruments (pince à servir, pince à disséquer avec et sans griffe, pince de Kocher, PEAN, MANDRIN, sonde cannelée, lame de bistouri, paires de ciseaux...) stériles ;
- Boîtes ou tambours de compresses stériles ;
- Flacons d'antiseptiques (Bétadine jaune, Bétadine rouge, alcool, dakin, éther, Mercryl, laurylé...) ;
- Matériel de contention (bande de crêpe, Velpeau ou gaze et du sparadrap) ;
- Coton hydrophile, coton cardé ;
- Médicaments prescrits (pommade, poudre, ATB).

4.2 Matériel courant

- Un chariot- deux plateaux - un haricot- gants stériles ou propres ;
- Du savon, serviette- une poubelle - une alèze.

V. TECHNIQUE proprement dite (Voir fiche d'apprentissage)

VI. PRECAUTIONS A PRENDRE

Lieu : il est fonction de l'état du malade

- Dans la salle de soin pour un pansement à titre externe ;
- Au lit du malade lorsqu'il s'agit d'un malade hospitalisé.

Tenue du soignant

- Blouse propre, repassée avec bouton et calot ;
- Bagues, montres et bracelets enlevés ;
- Chaussures fermées et silencieuses ;
- Cheveux bien peignés ;
- Ongles coupés courts.

III. DIFFERENTS TYPES DE PANSEMENT

Il existe plusieurs types de pansements.

3.1 Les pansements secs

3.1.1 Le pansement sec aseptique (exempt de germe)

C'est un pansement protecteur et qui s'applique sur une plaie aseptique. Exemple : plaie opératoire aseptique traumatisme non infecté. Il requiert une asepsie rigoureuse.

3.1.2 Le pansement sec antiseptique

C'est un pansement désinfectant qui a pour but de prévenir l'infection. Par exemple : suture périnéale.

3.2 Les pansements humides

3.2.1 Le pansement humide froid

Le pansement humide froid est indiqué dans les œdèmes et contusions. Il peut être renouvelé trois fois par jour.

3.2.2 Le pansement humide chaud

Le pansement humide chaud est un pansement qui se fait en cas d'hématome et d'abcès chaud. Il se fait avec du matériel stérile et le pansement est renouvelé trois fois par jour.

3.2.3 Le pansement humide alcoolisé

Il est indiqué dans le début de panaris et dans les lymphangites et se fait en mouillant la compresse avec l'alcool à 90°. Il est souvent renouvelé dans la journée.

3.2.4 Le pansement avec drain ou mèche

Il se fait après incision d'une collection purulente pour assurer l'écoulement du pus.

3.2.5 Le pansement absorbant

Il est indiqué dans les plaies suppurées.

Dans ce cas, on fait le plumasseau ou pansement américain qui consiste à mettre sur la plaie une couche de coton hydrophile et une couche de coton cardé, le tout emballé de gaze pour une absorption de sérosité.

3.3 Autres pansements

3.3.1 Pansement avec retrait d'agrafes

Faire le pansement comme un pansement ordinaire. Les agrafes doivent être retirées le 6^{ème} ou 8^{ème} jour suivant l'intervention. Il est bon de retirer une sur deux dans un 1^{er} temps vers le 4^{ème}, 6^{ème} jour et l'ablation totale intervient au 8^{ème} jour.

3.3.2 Le pansement avec retrait de fils

Il faut bien aseptiser les points de suture avant de les retirer. Avec la pince de Kocher, saisir le nœud et dégager le fil à sa base. Dans un 1^{er} temps, on retire 1 sur 2 au 7^{ème} jour et à partir du 10^{ème} jour intervient l'ablation totale.

3.3.3 Le pansement compressif

Il est indiqué dans les plaies ouvertes avec hémorragie externe.

3.3.4 Le pansement au tulle gras

Le pansement au tulle gras est très utilisé dans le traitement des brûlures ou à la suite d'une greffe épidermique.

IV. MATERIEL

Le matériel de pansement est composé comme suit :

4.1 Matériel spécifique

- Boîtes à instruments (pince à servir, pince à disséquer avec et sans griffe, pince de Kocher, PEAN, MANDRIN, sonde cannelée, lame de bistouri, paires de ciseaux.) stériles ;
- Boîtes ou tambours de compresses stériles ;
- Flacons d'antiseptiques (Bétadine jaune, Bétadine rouge, alcool, dakin, éther, Mercryl, laurylé...) ;
- Matériel de contention (bande de crêpe, Velpeau ou gaze et du sparadrap) ;
- Coton hydrophile, coton cardé ;
- Médicaments prescrits (pommade, poudre, ATB).

4.2 Matériel courant

- Un chariot- deux plateaux - un haricot- gants stériles ou propres ;
- Du savon, serviette- une poubelle - une alèze.

V. TECHNIQUE proprement dite (Voir fiche d'apprentissage)

VI. PRECAUTIONS A PRENDRE

Lieu : il est fonction de l'état du malade

- Dans la salle de soin pour un pansement à titre externe ;
- Au lit du malade lorsqu'il s'agit d'un malade hospitalisé.

Tenue du soignant

- Blouse propre, repassée avec bouton et calot ;
- Bagues, montres et bracelets enlevés ;
- Chaussures fermées et silencieuses ;
- Cheveux bien peignés ;
- Ongles coupés courts.

VII- IEC /CCC RELATIVE AU PANSEMENT

Cette activité consiste à :

- Expliquer au malade les bienfaits du pansement fait à l'hôpital par un personnel qualifié ;
- Conseiller le malade et/ou sa famille sur la nécessité de maintenir le pansement propre ;
- Déconseiller le malade ambulant d'utiliser les produits traditionnels sur une plaie ;
- Conseiller le malade ambulant de venir à l'hôpital s'il constate une anomalie au niveau de sa plaie ;
- Conseiller le malade de ne jamais défaire le pansement même si la plaie lui fait mal.

CONCLUSION

La maîtrise de la technique de pansement et l'observation des règles d'asepsie permettent d'éviter au malade des complications pouvant nuire à sa santé. Ainsi, tout personnel soignant doit pouvoir exécuter ce soin avec rigueur et habileté.

BANDAGE

OBJECTIF GENERAL

Connaitre le bandage.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir le bandage.
2. Déterminer le but d'un bandage.
3. Citer les indications du bandage.
4. Citer les différents types de bandage.
5. Citer le matériel d'un bandage.
6. Expliquer la technique du bandage.

I. DEFINITION

Le bandage est une méthode manuelle utilisée pour appliquer une bande de tissu souple sur une lésion bien déterminée d'une partie du corps

La bande peut être en gaze ou en crêpe Velpeau. Elle comporte 2 chefs ou extrémités : 1 chef initial par lequel on commence le bandage, 1 chef terminal pour terminer le bandage. La bande roulée constitue le globe.

II. BUTS

Le but est essentiellement thérapeutique et vise à :

- La protection pour maintenir un pansement en place ;
- L'immobilisation pour limiter les mouvements (cas d'entorses) ;
- La compression pour limiter les œdèmes, pour réaliser l'hémostase après une saignée ;
- Le soutien d'un membre ou d'un organe interne descendu (cas d'une hernie).

III. INDICATIONS

Fractures ouvertes ou fermées, entorses, plaies, hernies (personnes âgées), panaris, lésions prurigineuses et lésions méniscales du genou.

IV. DIFFERENTS TYPES DE BANDAGES

• Membres supérieurs

Coude : Le croisé du coude (ne pas envelopper le coude)

Doigts : Le spica du doigt (pouce, en cas de plaie ou de fracture du doigt)

• Membres inférieurs

Genou : L'enveloppement du genou (en cas de plaie étendue)

Le Baudens : en cas d'entorse de la cheville.

L'étrier ou croisé du coup de pied en cas de plaie de la malléole ou de dessus du pied.

Le chausson du pied dans les brûlures étendues, délabrements des orteils, malformations, pays tempérés etc...

V. MATERIEL

- Bandes propres (5 cm membres supérieurs, 10 cm membres supérieurs et membres inférieurs, 15 cm organes et chez les accouchées par exemple) ;
- Sparadrap ;
- Épingles de sûreté ;
- Coton cardé ou coton hydrophile selon le cas ;
- Compresse (pour séparer les doigts en cas de lésions prurigineuses) ;
- Plateau propre ou stérile.

VI. TECHNIQUE PROPREMENT DITE (voir Fiche d'apprentissage)

Elle dépend du bandage en général.

- Prendre le globe de la bande dans la main droite, le chef initial légèrement déroulé est tenu dans la main gauche ;
- Passer la bande de la main gauche à la main droite ;
- Commencer par deux (2) circulaires et terminer par deux (2) circulaires, puis fixer par un nœud double ou une épingle de sûreté ou avec un morceau de sparadrap ;
- Ne jamais défaire le rouleau (le globe) pendant le bandage.

Conditions d'un bon bandage

- Recouvrir entièrement toute la surface à bander ;
- Effectuer le bandage dans le sens de la circulation veineuse du bas en haut ;
- Un bandage ne doit être ni trop serré, ni trop lâche.

Pour éviter les accidents après un bandage, vérifier le pouls, les extrémités (coloration, chaleur, mobilité), respecter la position de fonction du membre.

IMMOBILISATIONS PROVISOIRES

OBJECTIF GENERAL

Connaitre l'immobilisation provisoire.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir l'immobilisation provisoire.
2. Déterminer le but et intérêt de l'immobilisation provisoire.
3. Citer les indications.
4. Décrire la technique.
5. Enumérer le matériel dans l'immobilisation provisoire.

INTRODUCTION

Dans la pratique infirmière, l'une des activités de soins les plus fréquentes sur le terrain est l'immobilisation provisoire de certaines blessures. Un infirmier ou une sage-femme où qu'il se trouve doit pouvoir faire face à ce type de soin.

Cette raison doit nous pousser à développer des habiletés précises pour faire les immobilisations provisoires qui constituent des gestes de mise en condition d'une victime et qui permettent de limiter les mouvements d'une partie du corps.

I. DEFINITION

- L'immobilisation est un soin d'urgence qui est réalisé chez certains blessés et permettant d'éviter une aggravation lésionnelle.
- L'immobilisation provisoire est une technique de contention qui consiste à maintenir en place de manière provisoire une partie du corps dans un but thérapeutique avec des écharpes, des gouttières, des attelles.

II. BUTS, INTERETS, INDICATIONS, PRECAUTIONS ET PRINCIPES GENERAUX DE L'IMMOBILISATION PROVISOIRE

2.1 Buts

- Eviter l'aggravation des lésions
- Supprimer toute possibilité de mouvement du membre blessé ;
- Eviter la transformation de la fracture fermée en fracture ouverte ;
- Eviter ou empêcher une atteinte secondaire des vaisseaux ou des nerfs ;
- Eviter tout déplacement osseux ;
- Améliorer le confort du blessé ;
- Diminuer le stress qui est facteur de complication ;
- Diminuer la douleur.

2.2 Intérêts

- Se perfectionner dans les soins
- Faciliter les transports des blessés à l'hôpital ;
- Porter secours ;
- Sauver des vies humaines.

2.3 Indications

Fractures, contusions, malformations, luxations.

2.4 Précautions à prendre au cours d'une immobilisation provisoire

- Interdire tout mouvement ;
- Enlever bagues et bracelets ;
- Mettre un coussinet au niveau des articulations ;
- Demander un (e) aide pour maintenir le bras en angle droit.

N.B :

- L'écharpe doit maintenir le bras en angle droit ;
- Fixer l'écharpe avec l'épingle de sûreté ;
- Eviter les mouvements spontanés ;
- Eviter les mouvements dangereux sur le malade ;
- Eviter les gestes intempestifs ;
- L'appareillage ne doit occasionner ni déplacement, ni position en porte-à-faux ;
- Il faut agir avec méthode pour engager le matériel autant que possible ;
- Faire des gestes doux et habiles ;
- Etre en possession de tout le matériel avant de commencer le soin ;
- Prévoir toujours un aide pour s'aider.

2-5. Principes généraux de l'immobilisation provisoire

L'immobilisation se fait en maintenant le membre en position de fonction.

- Utiliser du matériel non traumatisant
- Immobiliser l'articulation sus et sous-jacentes
- Respecter la déformation
- Rembourser spécialement (attelle et gouttière) au niveau des saillies osseuses

III. MATERIEL**3-1 Matériel spécifique**

Les matériels d'immobilisation provisoire à la disposition de l'infirmier ou de la sage-femme sont les attelles, les gouttières et les écharpes, le matelas coquille, les collerets cervicaux, les minerves.

3.1.1 Les Attelles (membres supérieurs et membres inférieurs)

- **Préparation d'une attelle :**
- Deux planches ou deux cannes ou deux bâtons
- Une bande ou une cravate ou un foulard ou une ceinture pour les liens
- Pour capitonner les attelles, il faut une veste, du coton ou un pagne etc...

3.1.2 Les gouttières (membres supérieurs et membres inférieurs)

- **Préparation d'une gouttière :**
- Une gouttière grillagée selon le membre blessé (droite ou gauche, membre supérieur ou inférieur) ;
- Un large morceau de gaze (compresse) -Un rouleau de coton cardé ;

- Deux bandes ;
- Deux coussinets (un sous le tendon d'Achille et l'autre sous le creux poplité)
- Deux sacs ou poches de sable -Un cerceau de lit ;
- Des épingles de sûreté -Du beurre de karité ou de la vaseline ;
- Un plant dur (posé suivant le type de matelas, soit sous le matelas, soit sous le drap de dessus).

3.1.3 Les écharpes (membres supérieurs)• **Définition**

Ce sont les différentes sortes de bandages réalisés avec des morceaux de tissus carrés ou rectangulaires dans le but d'immobiliser tout ou une partie du membre supérieur.

Il existe différentes sortes d'écharpes :

- Petite écharpe : dans les luxations du poignet ;
- Moyenne écharpe : luxation, plaie du poignet et fracture de l'avant-bras ;
- Echarpe de Jean-Louis-Petit : lésion de l'avant-bras et du coude ;
- Echarpe de Mayor : lésion du coude et de l'avant-bras ;
- Echarpe oblique ;
- Echarpe triangulaire.

• **Préparation d'une écharpe**

- Un morceau d'étoffe carrée de 1 mètre de côté ;
- De l'élastoplaste (sparadrap adhésif) ;
- Une bande, des épingles de sûreté.

3.2 Matériel courant

- Coton cardé- Coton hydrophile-Plateau ;
- Alcool - Gants- Chariot-Bandes- Compresse ;
- -Sparadrap - Bétadine jaune.

3.3 Préparation du malade

- Identifier le malade ;
- Evaluer son état de santé ;
- Evaluer l'état de la blessure ;
- Evaluer l'environnement immédiat du malade ;
- Expliquer le soin à faire au malade et/ou à sa famille ;
- Faire une préparation psychologique pour qu'il accepte le soin.

IV. TECHNIQUE (voir fiche Technique d'apprentissage)**CONCLUSION**

L'immobilisation provisoire est un soin de première intention pour l'infirmier dans le cadre du prompt secours des blessés. Les différents moyens de contention relevant de la compétence des infirmiers que sont les attelles, les gouttières et les écharpes sont dits provisoires d'où l'intérêt de bien connaître ces mesures pour les mettre en pratique dans les soins.

SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION CARDIO-VASCULAIRE

MESURE DE LA PULSATION OU POULS

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant en sciences infirmières et obstétricales de la licence 1 doit être capable de prendre le pouls d'un client.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir le pouls.
2. Enumérer les buts de la prise du pouls.
3. Enumérer les différents sites de prise du pouls.
4. Décrire la technique de la prise du pouls.
5. Donner les valeurs normales du pouls chez l'adulte, l'enfant, le nourrisson, le nouveau-né.

INTRODUCTION

L'appréciation des pulsations se réalise par la pression des doigts sur le trajet ou au moyen d'un appareil de mesure électronique.

La mesure des pulsations permet d'apprécier le rythme, la fréquence, l'amplitude, le caractère des battements cardiaques. Elle fait partie du recueil des informations qui concourent à la connaissance et à la surveillance de l'état de santé d'une personne.

I. DEFINITION

Le pouls est la sensation de soulèvement perçue par le doigt qui déprime une artère superficielle sur un plan osseux.

II. BUTS DE LA PRISE DU POULS

- Surveiller l'état de santé d'une personne ;
- Apprécier la fréquence et le rythme cardiaque ;
- Déceler des anomalies du fonctionnement de l'appareil cardio-vasculaire ;
- Evaluer la régularité et la force du pouls ;
- Apprécier les effets d'un traitement médicamenteux.

III. MATERIEL

- Un stylo rouge ;
- Une feuille de température ou un carnet de santé ;
- Une montre à trotteuse (ou appareil de mesure électronique).

IV. DIFFERENTS SITES OU MESURE DE LA FREQUENCE CARDIAQUE

Les pulsations peuvent être perçues à différents niveaux :

• Membres supérieurs :

Au niveau de l'artère radiale (pouls radial) Artère humérale.

• Face et cou

- Artère temporale ;
- Carotide externe (devant l'oreille) ;
- Carotide interne (en avant du cou).

• Membres inférieurs

- Artère fémorale (pli de l'aîne) ;
- Artère poplitée (sous le genou) ;
- Artère pédieux (coup de pied).

V. VARIATIONS DES PULSATIONS

Elles sont de deux ordres :

- Physiologique ;
- Pathologique.

1- Variations physiologiques

Elles varient suivant certains facteurs

- l'âge

Fœtus	140 à 160 pulsations/mn
A la naissance.....	130 à 140
A 4 mois	130
A 1 an.....	100 à 130
A 5 ans	100
A 14 ans	81 à 85
Adulte.....	60 à 80
Vieillard.....	60 à 70

- **Emotion** : Toute émotion provoque une accélération du rythme

- **Effort** : Accélération du rythme correspondant à l'accélération des contractions cardiaques.

2- Variations pathologiques

Elles varient selon l'état du cœur et sont en rapport avec la rapidité, la régularité et l'amplitude cardiaque.

- La tachycardie : fréquence accélérée au-dessus de 100/ mn chez l'adulte
- Cela se voit en présence d'une émotion, d'un effort, de la prise de café, Tabac.
- La bradycardie : fréquence ralentie au-dessous de 60 pulsations par minute chez l'adulte.

VI. TECHNIQUE (voir TP)

MESURE DE LA TENSION OU PRESSION ARTERIELLE

OBJECTIF GENERAL

A la fin du cours, l'étudiant en sciences infirmières de la licence 1 doit être capable de prendre une pression artérielle d'un client.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir la pression artérielle.
2. Citer les 2 buts de la mesure de la pression artérielle.
3. Décrire la technique auscultatoire de la mesure de la pression artérielle.
4. Citer les valeurs normales de la pression artérielle.
5. Citer les 5 conseils pratiques pour une bonne prise de la pression artérielle.

INTRODUCTION

La mesure de la tension artérielle est un acte de soin qui consiste à apprécier la mesure de la pression selon laquelle le sang circule dans les artères.

L'appréciation de la pression artérielle fait partie des informations qui concourent à la connaissance et à la surveillance de l'état de santé d'une personne.

La mesure de la pression artérielle se fait au moyen d'un tensiomètre.

Il s'agit de mesurer la pression artérielle en position couchée bras le long du corps, en position assise et en position debout de l'artère brachiale placée au même niveau que le cœur.

I. DEFINITION

La tension artérielle est la pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux. La TA s'exprime en mmHg

Elle dépend surtout de :

- la force de contraction du cœur
- l'état des vaisseaux
- la masse sanguine

II. VALEURS NORMALES DE LA P A

Les valeurs normales de la P A sont comprises entre :

- de 90 mm/Hg à 140 mm/Hg pour la Systolique
- de 50 mm/Hg à 90 mm/Hg pour la Diastolique.

III. BUTS

- Surveiller la santé d'une personne ;
- Identifier les signes d'aggravation subite de l'état du patient (choc) ;
- Surveiller un patient en période postopératoire ;
- Surveiller les chiffres de pression artérielle ;

- Comparer les résultats en fonction des positions debout/couché ;
- Apprécier les effets d'un traitement antihypertenseur.

IV. VARIATIONS

1. Variation physiologique

- **L'âge** : Nouveau-né : 6/3 - Adulte : 12/7 - Vieillard : 16/9
- **L'émotion et l'effort physique**
- **L'heure** : elle est plus basse le matin et pendant le sommeil ; elle s'élève pendant les activités
- **les positions corporelles** : elle est plus basse en position couchée

2. Variation pathologique

- Hypertension artérielle ;
- Hypotension artérielle.

V. CONSEILS PRATIQUES

- Il peut être nécessaire d'effectuer des mesures bilatérales afin de révéler une éventuelle asymétrie tensionnelle.
- La P A répond aux lois de la physique et peut donc varier selon la position.
- Un test dit d'Hypotension Orthostatique peut être pratiqué en effectuant une mesure en décubitus dorsal, puis en position debout.
- Les valeurs seront surestimées avec un brassard trop petit et sous-estimées avec un brassard trop grand.
- Une contracture musculaire peut fausser la mesure ; d'où l'intérêt de mettre le patient au repos au moins 10mn dans une situation détendue.
- Ne jamais effectuer de mesure sur un bras porteur de fistule artérielle veineuse.

VI. MATERIEL

La mesure se fait à l'aide d'un appareil appelé tensiomètre. Il est composé de :

- Un manomètre gradué de 1 à 30 cm Hg ;
- Un brassard pneumatique ;
- Une poire servant à gonfler le brassard ;
- Un stéthoscope.

Il existe des tensiomètres électroniques.

VII. TECHNIQUE PROPEMENT DITE (voir TP)

INJECTIONS PARENTERALES

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant en sciences infirmières et obstétricales de la L1 doit être capable de préparer et réaliser une injection.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir l'injection.
2. Enumérer les différents types d'injections enseignées.
3. Citer les éléments de la préparation et de la réalisation d'une injection.

GENERALITES

Les injections sont des actes invasifs sur prescription médicale.

- Quel que soit la voie utilisée, les injections doivent s'effectuer dans des conditions d'asepsie rigoureuse.
- Les injections permettent d'éviter le tractus digestif.
- Les injections permettent un dosage plus précis et une action plus rapide.

I. DEFINITION GENERALE

Une injection est l'introduction sous pression dans l'organisme, d'une substance médicamenteuse fluide au moyen d'une seringue munie d'une aiguille creuse.

II. VOIES D'INJECTION

Il existe 4 types d'injection selon la voie d'abord ou voie utilisée

- 1- Injection Intradermiques (ID) : Absorption lente
- 2- Injection Sous Cutanée (SC) : Absorption lente
- 3- Injection Intra Musculaire (IM) : Absorption rapide
- 4- Injection Intra Veineuse (IV) : Absorption très rapide

III. PREPARATION DU MATERIEL

1. Matériel standard

De nos jours, le matériel est en emballage à usage unique.

Seringue- Aiguille - Produit injectable - Solutions antiseptiques (Lavage des mains, Désinfectant du site d'injection) - Plateau nettoyé et décontaminé - Gants propres ou stériles - Réniforme (Haricot) - Coton hydrophile - Compresses - Sparadrap, Sac poubelle.

2. Matériel spécifique : Selon le type d'injection.

IV. PREPARATION ET REALISATION DU SOIN (voir séance de TP)

1. Préparation du soin

- Se laver les mains ou les désinfecter ;
- Vérifier la prescription médicale : le nom du patient, la prescription, le dosage, les périodes de l'injection
- Vérifier l'intégralité des emballages (seringues, médicaments...) avant de les ouvrir.
- Préparer les tampons alcoolisés (au moins 5)

• Si ampoule cassable :

- Faire descendre le produit dans l'ampoule en tapotant le haut, puis désinfecter le collet avant de le casser ;
- Aspirer le produit en tirant délicatement sur le piston ;
- Faire le vide d'air en tenant la seringue avec l'aiguille vers le haut ou en tapotant la seringue jusqu'à ce que les bulles d'air remontent pour être expulsées.

En cas de dissolution d'une poudre dans un flacon

- Enlever le centre de la capsule métallique ;
- Désinfecter le bouchon en caoutchouc ;
- Aspirer la quantité de solvant nécessaire ;
- L'injecter dans le flacon puis agiter et/ou attendre la dissolution complète ;
- Aspirer le contenu lorsqu'il est homogène.

2. Installation du patient

- Respecter l'intimité du patient ;
- Aider le patient à s'installer si nécessaire ;
- Veiller au confort du patient ;
- Informer le patient du soin à effectuer ;
- Répondre aux questions du patient ;
- Préparer le lieu de l'injection
- Vérifier l'état de la peau : s'assurer qu'il n'y a ni lésion, ni hématome, ni inflammation, ni œdème.

3. Technique selon le type d'injection (voir TP)

4. Surveillance du patient à la recherche de :

- Incidents : Douleurs, Hématome, Extravasation ;
- Accidents : Choc Anaphylactique.

INJECTION INTRADERMIQUE

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant en sciences infirmières et obstétricales de la L1 doit être capable de réaliser une injection intra dermique.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir l'injection intradermique
2. Citer l'indication de l'injection intradermique
3. Enumérer les sites de l'injection intradermique
4. Décrire la technique de l'injection intradermique

I. DEFINITION

L'injection intradermique (ID) est l'introduction dans le derme d'une solution biologique ou chimique.

II. INDICATION : Injection de vaccins

III. MATERIEL SPECIFIQUE

- Seringue 1cc ou 1ml ;
- Aiguille fine ;
- Substance à injecter.

IV. SITES D'INJECTION

- Face interne de l'avant-bras ;
- Face externe du bras.

V. INSTALLATION DU PATIENT

- Faire asseoir ou coucher le patient en fonction de sa sensibilité.

VI. TECHNIQUE SPECIFIQUE (voir séance de TP)



INJECTION SOUS-CUTANEE

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant en sciences infirmières et obstétricales de la L1 doit être capable de réaliser une injection sous cutanée.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir l'injection sous cutanée.
2. Donner les indications de l'injection sous cutanée.
3. Enumérer les voies d'abord de l'injection sous cutanée.
4. Décrire la technique de l'injection sous cutanée.

I. DEFINITION

L'injection sous-cutanée (SC) est l'introduction sous pression, d'une substance médicamenteuse dans les tissus conjonctifs lâches sous-cutanés.

II. INDICATIONS :

- Administration d'anticoagulant ;
- Administration d'anesthésie locale ;
- Administration d'insuline (traitement du diabète).

III. SITES D'INJECTION

- Face externe des bras ;
- Face supéro-externe des cuisses ;
- Région sus et sous-épineuse de l'omoplate ;
- Région abdominale s'étendant en dessous du rebord costal jusqu'à la crête iliaque.

IV. MATERIEL

- Plateau stérile ;
- Produit à injecter ;
- Seringue stérile 1 ml à 20 ml en fonction de la quantité du produit à injecter ou seringue à insuline ou dispositif près à l'emploi ;
- Aiguille sous-cutanée (orange : 25 Gauge, marron : 26 Gauge) ;
- Compresses non stériles ou boules de coton ;
- Antiseptique ou alcool modifié à 70° ;
- Compresse et sparadrap. ;
- Gants non stériles à usage unique ;
- Réniforme (haricot) ;
- Sac à élimination des déchets ;
- Conteneur à déchets contaminés piquants et tranchants ;
- Désinfectant de surface et une mousse à nettoyage ;
- Nécessaire à l'hygiène des mains.

V. PREPARATION DU MATERIEL SPECIFIQUE

- Seringue de 0,5 à 2,5ml ;
- Aiguille sous-cutanée ;
- Substance à injecter ;
- Seringues pré-remplies.

VI. TECHNIQUE DE L'INJECTION SOUS-CUTANEE (voir séance de TP)

Deux techniques sont utilisées selon l'angle d'injection :

- Injection à 45°
- Injection à 90°

• Installation du patient :

Faire asseoir ou coucher le patient quel que soit l'angle d'injection (45° ou 90°)

• En cas d'injection d'anticoagulants

- Il n'est pas nécessaire d'aspirer pour savoir si l'on se trouve dans un vaisseau ou pas ;
- Ne pas chasser la bulle d'air de la seringue prête à l'emploi ;
- Piquer à un angle de 90° ;
- Retire l'aiguille sans masser.

NB : L'injection des Anticoagulants se fait uniquement dans la région abdominale.

INJECTION INTRA-MUSCULAIRE (IM)

OBJECTIF GENERAL

A la fin du cours, l'étudiant en sciences infirmières et obstétricales de la L1 doit être capable de réaliser une injection intramusculaire.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir l'injection IM.
2. Citer les indications de l'injection IM.
3. Citer les 3 lieux d'élection de l'injection IM avec les différents avantages ou inconvénients de chacun.
4. Repérer sur un schéma le lieu d'injection IM du muscle moyen fessier.

I. DEFINITION

L'injection intramusculaire (IM) est l'introduction sous pression d'une substance médicamenteuse dans le muscle.

II. INDICATIONS :

- Intolérance de la voie orale ;
- Etat du patient ;
- Médicament sous forme injectable seulement.

III. MATERIEL SPECIFIQUE

- Produit pour injection IM ;
- Seringue avec aiguille adaptée pour une IM.

IV. LIEU D'ELECTION OU LIEU D'INJECTION

Ils sont au nombre de trois (03) :

- Muscle moyen fessier ;
- Muscle vaste externe ;
- Muscle deltoïde.

4.1 Le muscle moyen fessier

Avantage : Situé loin des principaux nerfs et vaisseaux.

Repérage : Quart supéro-externe du quadrant supéro externe de la fesse.

4.2 Le muscle vaste externe

C'est un muscle volumineux et bien développé qui se situe entre le genou et le grand trochanter du fémur.

Avantage : Pas de présence de nerfs ni de vaisseaux ; L'absorption du produit est rapide.

4.3 Le muscle deltoïde

Inconvénients : Présence des nerfs radial et cubital ;

- Présence de l'artère brachiale ;
- Il ne peut que recevoir que des injections de petites quantités ;
- L'injection doit se faire dans un angle de 90°.

V. PREPARATION DU MATERIEL

- Identique à toutes les injections

VI. PREPARATION ET REALISATION DU SOIN

- Préparation du soin (Commune à toutes les injections)

VII. INSTALLATION

7.1 Injection dans le muscle moyen fessier

Installer le patient sur le côté, avec une légère flexion de la hanche et du genou, ce qui favorise la décontraction.

7.2 Injection dans le muscle vaste externe

- Installer le patient sur le dos, le genou légèrement fléchi ou en position assise pour favoriser la décontraction ;
- Chez les patients cachectiques et les enfants, il est recommandé de saisir la masse musculaire pour s'assurer que l'injection se fait dans le muscle.

7.3 Injection dans le muscle deltoïde

- Ici le patient peut être assis, debout ou couché.
- Il faut découvrir complètement le bras et l'épaule du patient.
- Dire au patient de laisser pendre le bras pour le décontracter.

VIII. INCIDENTS ET ACCIDENTS

- Identiques à toutes les injections.

INJECTION INTRA-VEINEUSE (IV)

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant en sciences infirmières et obstétricales de la L1 doit être capable de réaliser une injection intraveineuse.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir l'injection intraveineuse.
2. Donner les indications de l'injection intraveineuse.
3. Citer les veines les plus utilisées dans l'injection intraveineuse.
4. Décrire la technique de l'injection intraveineuse.

I. DEFINITION

L'injection Intraveineuse (IV) est l'introduction d'une substance médicamenteuse fluide dans la circulation générale à travers une veine.

II. INDICATIONS

- Intolérance de la voie orale ;
- Urgence dans le traitement ;
- Etat du patient.

III. MATERIEL SPECIFIQUE

- Garrot, Seringue + Aiguille adaptées ;
- Produits pour injection IV ;
- Siège pour l'infirmier.

IV. CHOIX DE LA VOIE VEINEUSE

Chez l'adulte on choisit généralement la veine la plus saillante et la plus accessible.

4.1 Veines du membre supérieur

- Veine du pli du coude ;
- Veine de l'avant-bras ;
- Veine du dos de la main ;

4.2 Membre inférieur

Ici il y a un grand risque de thrombose.

V. INSTALLATION

Le patient doit toujours être installé en décubitus dorsal.

VI. TECHNIQUE DE L'INJECTION IV (voir séance de TP)

VII. INCIDENTS ET ACCIDENTS

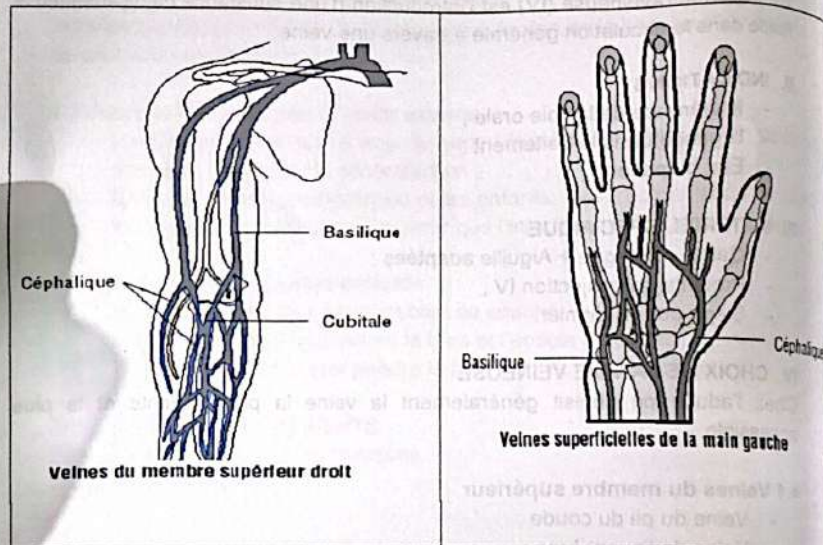
Communs à toutes les injections

VIII. SURVEILLANCE

Commune à toutes les injections.

NB :

Choix de la veine du membre supérieur : la veine doit être droite sans courbure loin d'une région osseuse ou du pli.



INJECTION LENTE PAR DISPOSITIF INTRAVEINEUX

OBJECTIF GENERAL

Réaliser une injection lente par dispositif intraveineux.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir l'injection lente par dispositif intraveineux.
2. Citez tout le matériel du soin sans oublier les indications.
3. Expliquer les risques et complications relative au soin.
4. Expliquer les éléments de surveillance et d'évaluation du soin.

I. DEFINITION

L'injection lente par dispositif intraveineux (injection intra-tuyaux) est l'administration d'un produit médicamenteux présenté sous forme injectable par la voie d'un dispositif intraveineux déjà posé (cathéter).

II. INDICATION

Nécessité d'une action rapide.

III. MATERIEL

- Un plateau stérile ;
- Produit à injecter ;
- Présentation du produit :
- Seringue stérile de 1ml à 20ml en fonction de la quantité du produit à injecter.
- Poche pour perfusion avec tubulure.
- Bouchon stérile pour site d'injection (robinet).
- Compresses stériles.
- Antiseptique.
- Réniforme (haricot).
- Sac à élimination des déchets.
- Conteneur à déchets contaminés piquants et tranchants.
- Désinfectant de surface et une mousse.
- Nécessaire à l'hygiène des mains.

IV. TECHNIQUE DU SOIN (Voir TP)

V. RISQUE ET COMPLICATION

Choc anaphylactique - réaction allergique.

VI. SURVEILLANCE ET EVALUATION

- Surveillance du point de ponction du cathéter ;
- Surveillance du débit ;
- Surveillance des réactions possibles du patient pendant et après l'injection.

VII. LES INCIDENTS ET ACCIDENTS LIES AUX INJECTIONS

Les incidents et accidents survenant à la suite d'erreur ou de faute de technique sont imputables à l'infirmier ou à la sage-femme ; il ou elle peut être tenu(e) responsable devant les tribunaux.

1. Les incidents et les accidents liés aux erreurs

Les erreurs de médicaments peuvent être redoutables pour cela il faut :

- Bien vérifier le nom du médicament injecté (la dose prescrite et la dose de l'ampoule
- Vérifier le nom du malade et non le numéro du lit.
- Ne jamais préparer dans un même plateau plusieurs injections pour des malades différents.
- Préparer l'injection au lit du malade ou à la porte de sa chambre
- Si l'injection est préparée en salle de soin, n'en préparer une à la fois.

2. Les erreurs dans les modes d'injection.

- Un produit injecté par voie ultra veineuse alors qu'il devrait être parfois intra musculaire ou sous cutané peut déclencher un état de choc.
- Un produit injecté par voie IM ou sous cutané alors qu'il devrait l'être par voie intraveineuse, peut provoquer une escarre...
- Bien vérifier le mode d'injection sur la prescription et sur l'ampoule, en cas de doute se renseigner auprès du médecin traitant avant de faire l'injection.

3. Incidents et accidents liés au mauvais choix du lieu d'injection

L'injection au niveau du nerf sciatique provoque une douleur immédiate mais peut entraîner par la suite une sciatique. L'injection sur l'os peut entraîner la rupture de l'aiguille dans le corps.

4. Fautes d'asepsie

Elles peuvent être nombreuses au moment de la préparation et de l'exécution du soin :

- Doigts mis sur l'embout ou sur le piston, aiguille ayant touché l'extérieur de l'ampoule ou le chariot ;
- Mauvaise désinfection de la peau etc. ;
- Ces fautes d'asepsie favorisent l'apparition d'abcès souvent profond lors de l'injection intramusculaire et nécessite une incision chirurgicale.

5. Mauvaises stérilisations

Une stérilisation défectueuse peut favoriser l'apparition d'abcès et d'hépatite virale.

6. Incidents et accidents liés au médicament lui-même.

Les incidents et accidents liés au médicament lui-même ne sont pas imputables à l'infirmier ou à la sage-femme. Mais il ou elle doit les connaître et s'efforcer de les prévenir :

• La mauvaise résorption du produit

Certains médicaments en particulier les substances huileuses se résorbent difficilement.

Il peut se produire une collection

Pour prévenir cet accident il faut varier les points d'injection.

• Les réactions allergiques

Certains médicaments peuvent déclencher dans l'organisme des réactions allergiques.

- réactions locales (urticaire, œdème)
- réactions générales (choc anaphylactique)

• La prévention du choc anaphylactique

La prévention du choc anaphylactique est possible en refusant toute injection à un malade déjà sensibilisé au produit de par l'interrogatoire et il faut rechercher des signes d'intolérance :

Prurit, urticaire œdème au point de piqure au cours d'un traitement précédent, malaise général, céphalée à la suite des injections précédentes.

• Le traitement du choc anaphylactique

Il doit être immédiat :

- injection IV d'hydrocortisone ou de soludécadron ;
- une réanimation doit être entreprise aussi tôt suivant l'état du malade ; respiration artificiel, massage cardiaque externe, oxygénation.

VIII. LA CCC

La communication pour le changement de comportement consiste à donner des conseils en rapport avec le soin au client :

- L'hygiène corporelle (se laver après une injection) ;
- Éviter l'automédication ;
- Consulter toujours le personnel médical en cas d'anomalie ;
- Éviter de fréquenter les infirmeries de quartier ;
- Déconseiller au malade de masser le site d'injection avec de l'eau chaude ;
- Déconseiller le massage du site avec des chaussures.

NB : pour l'infirmier ou la sage-femme les injections ne doivent se faire que par nécessité, il faut toujours privilégier la voie orale si possible.

PRELEVEMENT DE SANG PAR PONCTION VEINEUSE

OBJECTIF GENERAL

Réaliser un prélèvement de sang par ponction veineuse.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir le prélèvement de sang par ponction veineuse selon le cours.
2. Citer les indications du prélèvement de sang par ponction veineuse.
3. Enumérez le matériel du prélèvement de sang.
4. Expliquer les risques et les complications du prélèvement de sang.
5. Expliquer les éléments de surveillance du prélèvement.

I. DEFINITION

La ponction veineuse est le prélèvement d'un échantillon de sang veineux afin de réaliser une analyse de biologie médicale.

II. INDICATIONS :

- Dépister des troubles biologiques ;
- Aider au diagnostic ;
- Suivre l'évolution d'un traitement ou d'une maladie.

III. MATERIEL

- Système de prélèvement :
- Corps de pompe à usage unique (vacutainer) -Aiguille à monter s'adaptant au corps de pompe -Gants non stériles à usage unique -Garrot.
- Aiguille épicroténienne équipée d'une tubulure et d'un adaptateur au corps de pompe.
- Seringue stérile et aiguille-Tube(s) de prélèvement sous vide selon les analyses
- Antiseptique ou alcool modifié à 70°-Compresse non stériles ou boules de coton
- Protection papier absorbante à usage unique-Etiquettes laboratoire d'identification patient- Bons d'analyses laboratoire, avec pochette de transport.
- Sac à élimination des déchets-Nécessaire à l'hygiène des mains
- Conteneur à déchets contaminés piquants et tranchants.
- Désinfectant de surface et une mousse.

IV. REALISATION DU SOIN (voir séance de TP)

V. COMPLICATIONS

- Hématome au point de ponction : bien comprimer le point de ponction après le prélèvement ;
- Défaut de reflux du sang : non ponction de la veine, transperçement de la veine, veine trop ou pas assez comprimée ;
- Douleur.
- Malaise vagal : stopper le soin, mettre le patient en décubitus.

VI. SURVEILLANCE

- Surveillance du point de ponction.

PERFUSION INTRAVEINEUSE

OBJECTIF GENERAL

L'étudiant en sciences infirmières et obstétricales de la licence 1 doit être capable de réaliser une perfusion.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

- 1-Définir la perfusion intraveineuse
- 2-Citer les indications de la perfusion
- 3-Enumérer les veines des membres supérieurs à ponctionner dans une perfusion
- 4-Citer les sites de ponction contre indiqués
- 5-Citer les différents éléments de surveillance de la perfusion
- 6-Enumérer les incidents et accidents de la perfusion.

GENERALITES

Il existe la perfusion veineuse périphérique et perfusion veineuse centrale. La perfusion veineuse périphérique est un acte sur prescription médicale (la pose comme le retrait). La perfusion veineuse centrale est réalisée que par le médecin. La pose d'un cathéter veineux s'effectue toujours dans des conditions aseptiques rigoureuses, sauf en cas d'urgence vitale.

I. DEFINITION

La perfusion est un acte invasif qui consiste à l'administration lente et continue d'une substance médicamenteuse dans l'organisme par voie veineuse périphérique ou centrale.

II. PERFUSION VEINEUSE PERIPHERIQUE

1. Indications

- Apports hydriques et/ou électrolytiques ;
- Injection de médicament ;
- Nutrition parentérale ;
- Perfusion de produits sanguins labiles.

2. Sites de ponction

Privilégier les veines distales afin de préserver le capital veineux.

2.1 Veines des membres supérieurs

- Les veines du dos de la main sont souvent de petits calibres et fragiles ;
- Les veines radiales et cubitales sont recommandées ;
- Les veines des plis du coude sont réservées aux situations d'urgence.

2.2 Veines des membres inférieurs

Elles sont à utiliser avec prudence et pour une courte durée surtout chez l'adulte du fait de risque septique et thrombotique majeur.

2.3 Veines de la tête

Utilisées le plus souvent chez les nouveau-nés et les enfants.

2.4 Sites de ponction contre-indiqués

Il est formellement contre-indiqué de poser une perfusion sur : Bras ayant une fistule artérioveineuse

- Bras ayant subi un curage ganglionnaire ;
- Existence de lésion cutanées infectieuses ou lymphangite ;
- bras hémiparétique.

III. PREPARATION ET POSE D'UNE PERFUSION

La perfusion et la pose d'une perfusion respecte la chronologie suivante :

4.1 Préparation du matériel nécessaire

- Matériel nécessaire au lavage des mains
- Un chariot de soins
- Un Plateau nettoyé et décontaminé
- Un réniforme ou haricot
- Un Garrot
- Des gants non stériles
- Des compresses stériles ou du coton hydrophile
- Du sparadrap
- Antiseptique cutané (Bétadine, alcool ...)
- Tubulure de perfusion protection ou alèze
- Robinet à 3 voies ou rampe multivoies
- Un prolongateur
- Plusieurs cathéters veineux périphériques (adaptés à la taille des veines) ou épicroténienne
- Un container à aiguilles
- Le ou les solutés cristalloïdes
- Une potence
- Du soluté, des électrolytes, ou des médicaments selon prescription médicale
- Des flacons de prélèvement si nécessaire
- Cathéters veineux courts : le choix du calibre dépend de l'âge, de l'état veineux du patient, du traitement et de sa durée, du débit de la perfusion.

4.2 Technique de pose (voir séance de TP)

IV. SURVEILLANCE DE LA PERFUSION

5.1 Surveillance du matériel

- Surveillance du débit ;
- Surveillance de la chambre compte-goutte (remplie 3/4) ;
- Surveillance de la tubulure ou ligne de perfusion (bouchée, coudée, présence de sang dans la tubulure) ;
- Surveillance du ballon (niveau de remplissage).

5.2 Surveillance locale

- Surveillance du point de ponction à la recherche de signe d'inflammation locale : (rougeur, douleur, chaleur, œdème induration veineuse) ;
- Surveillance de l'état du pansement (pansement mouillé) ;
- Surveillance du bras perfusé (diffusion dans le tissu sous cutané).

5.3 Surveillance de l'état Général du patient (fièvre, sueur, frisson, ...)

V. INCIDENTS ET ACCIDENTS

6.1 Différents types

- Hématome par blessure de la veine ou par la plaie artérielle lors de la pose ;
- Infection sur cathéter (pouvant évoluer vers une septicémie) ;
- Vanité (invasion de l'endothélium veineux) ;
- Thrombophlébite superficielle (inflammation de la veine avec formation d'un caillot) ;
- Extravasation avec possibilité de nécrose cutanée.

6.2 Conduite à tenir

- Ablation du cathéter ;
- Si hématome ; compression manuelle immédiate, puis pansement compressif ;
- Si inflammation locale simple : faire un pansement alcoolisé ;
- Si infection : faire une culture de l'extrémité du cathéter, éventuellement une hémoculture si fièvre.

SÉCURITÉ DES INJECTIONS ET IMPACT DES INJECTIONS A RISQUE

OBJECTIF GENERAL

A la fin du cours l'étudiant doit connaître les effets néfastes des injections à risque sur la santé.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir selon le module la notion de sécurité des injections.
2. Décrire les principes de base des conditions de sécurité des injections.
3. Citer les pratiques des injections à risque selon le type de population.
4. Énumérer trois (3) obstacles à une injection sécurisée.
5. Énumérer les conséquences des injections à risque.

I. DÉFINITION DE LA NOTION DE SÉCURITÉ DES INJECTIONS

1. Sécurité des injections

C'est l'ensemble des dispositions et des pratiques qui concourent à faire des injections nécessaires, sans danger, avec du matériel stérile détruit par la suite selon les normes de sécurité.

2. Gestion des déchets médicaux

C'est un processus visant à garantir l'hygiène des établissements sanitaires, la sécurité de l'agent de santé, du client, de la communauté et de l'environnement.

Ce processus inclut :

- Le tri des déchets ;
- La collecte des déchets aux points de stockage ;
- Le stockage des déchets ;
- Le transport des déchets ;
- La destruction des déchets.

3. Risque infectieux

C'est la possibilité de contamination des suites de l'utilisation du matériel d'injection souillé.

4. Contrôle et prévention de l'infection

C'est la maîtrise de tous les facteurs pouvant entraîner une infection tant au niveau des personnels soignants et des clients que de la communauté et l'environnement.

II. PRINCIPES DE BASE

- Utiliser un système seringue-aiguille autobloquant stérile pour chaque injection.
- Utiliser une seringue et une aiguille jetables pour reconstituer chaque produit injectable.

- Eviter de contaminer le matériel d'injection.
- Préparer chaque injection dans un lieu propre, prévu à cet effet et où il y a peu de risques de contamination par du sang ou des liquides organiques.
- Percer toujours le septum des flacons multi dose avec une aiguille stérile.
- Ne pas laisser d'aiguille plantée dans le bouchon.
- Se protéger les doigts avec un petit tampon de gaze pour casser les ampoules.
- Jeter toute aiguille qui a été en contact avec une surface non stérile (mains, surfaces environnantes).
- Anticiper et prendre des précautions pour éviter un mouvement brusque du patient pendant et après l'injection.
- Pour éviter de se piquer, ne pas encapuchonner les aiguilles usagées et les déposer directement dans un réceptacle de sécurité.
- Jeter les seringues et aiguilles usagées dans un réceptacle de sécurité au point d'utilisation et le fermer hermétiquement quand il est plein (ne pas transvaser le contenu ni trop remplir le réceptacle).
- Transporter les réceptacles de sécurité fermés dans un lieu sûr. Ne pas les ouvrir, les vider ou les réutiliser.
- Éliminer les déchets des injections selon un procédé efficace et respectueux de l'environnement.
- Éviter les accidents dont pourrait être victime le personnel chargé d'éliminer les déchets.
- Ne pas mettre de flacons vides dans les réceptacles de sécurité car ils risqueraient d'exploser en brûlant.
- Ne mettre que du matériel d'injection usagé dans les réceptacles de sécurité.
- Ne pas y mettre de flacons vides, de coton, de compresses, etc.

III. PRATIQUES A RISQUE D'UNE INJECTION

Les pratiques à risque sont liées au non-respect des conditions de sécurité des injections selon le type de population, les pratiques des injections, représentent des risques potentiels que le praticien se doit d'éviter.

1. Pratiques à risque pour les personnes qui reçoivent les injections

- Réutiliser une seringue ou une aiguille
- Stériliser sans superviser ou surveiller le temps, la vapeur et les indicateurs de température
- Changer l'aiguille, mais réutiliser la seringue
- Faire une injection lorsqu'il y a des alternatives plus sûres
- Tenter de stériliser du matériel d'injection sans l'avoir nettoyé au préalable
- Tenter de stériliser et de réutiliser une seringue jetable
- Faire bouillir le matériel d'injection dans un récipient ouvert

- Utiliser uniquement des désinfectants sur les seringues et les aiguilles pour les préparer à la réutilisation
- Charger les seringues avec des doses multiples et faire des injections à plusieurs personnes
- Appuyer sur le point de saignement avec du matériel usagé ou le doigt
- Laisser une aiguille plantée dans le flacon pour prélever, les doses supplémentaires
- Flamber les aiguilles
- Toucher l'aiguille avant l'utilisation
- Stériliser sans tenir compte des paramètres de la stérilisation (temps, indicateurs de température)
- Stériliser du matériel d'injection sans l'avoir nettoyé au préalable.
- Stériliser et réutiliser une seringue jetable
- Désinfecter les seringues et les aiguilles pour les préparer à la réutilisation
- Disposer plusieurs seringues chargées de différents clients dans un même plateau.
- Utiliser un autre désinfectant que l'alcool.

2. Pratiques à risque pour les agents de santé

- Encapuchonner les aiguilles ;
- Détacher l'aiguille de la seringue avec la main ;
- Placer les aiguilles sur une surface et les transporter sur une certaine distance avant de les jeter ;
- Aiguiser les aiguilles émoussées ou bloquées pour les réutiliser ;
- Plonger la main dans une grande quantité de seringues ou d'aiguilles (pour nettoyer ou trier les déchets).

3. Pratiques à risque pour la communauté

- Laisser les seringues usagées dans des endroits où les enfants peuvent avoir accès.
- Donner ou vendre des seringues déjà utilisées
- Laisser les seringues usagées dans des endroits accessibles au public.

IV. OBSTACLES A UNE INJECTION SÉCURISÉE

1. Obstacles liés aux prestataires de soins.

- Méconnaissance : manque d'information et de formation des agents ;
- Incompétence : absence d'habileté pour réaliser une injection sécurisée ;
- Imprudence : non-respect des consignes pour une injection sécurisée été la négligence de l'agent ;
- Inconscience de l'agent.

2. Obstacles liés aux matériels

- Matériel périmé.
- Matériel défectueux : aiguilles usées qu'on aiguisé dans le but de les réutiliser
- Matériel insuffisant : indisponibilité de seringues autobloquantes qui entraîne la réutilisation des seringues usées
- Seringue à utilisation multiple
- Matériel inadapté ; seringue à utilisation complexe

V. CONSÉQUENCES DES INJECTIONS A RISQUE

Toute injection dangereuse cause des infections, des lésions et des problèmes liés à la substance administrée.

Les infections les plus graves et les plus courantes, transmises par les injections à risque sont :

- l'hépatite B,
- l'hépatite C
- le VIH/sida
- le virus d'Ebola.

Schéma des conséquences des injections dangereuses

INFECTIEUSES		NON INFECTIEUSES	
Transmission pathogènes par le sang	Autres infections dues à un matériel non stérile	Techniques d'injections incorrectes	Réactions dues à l'injection de substances incorrectes
Hépatite B Hépatite C VIH/sida, Ebola	Septicémies, Tétanos	Paralysie traumatique Becegites Adénites	Choc anaphylactique



Un incinérateur

**CALCUL DES DOSES ET POURCENTAGE DES MEDICAMENTS****OBJECTIF GENERAL**

Appréhender les règles de calculs des doses et des pourcentages des médicaments.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Décrire les différentes méthodes de calcul.
2. Enumérer toutes les correspondances en matière d'administration des médicaments.

I. LES REGLES DE CALCUL**1. La règle de trois**

La règle de trois consiste à calculer une inconnue avec trois données.

Dans un premier temps, on effectue une division des deux données aux unités différentes pour obtenir la valeur de la proportion correspondant à une unité de l'inconnue recherchée.

Exemple : Vous devez injecter 250mg d'Aspégic à un patient et pour cela vous disposez d'un flacon de 500mg et de 5ml d'eau pour préparation injectable. Calculez le nombre de ml de solution à injecter.

1- Calculons combien de ml représente 1mg de produit

$$5/500 = 0.01 \text{ donc } 1\text{mg} = 0,01\text{ml d'Aspégic}$$

2- Dans un second temps, combien de ml représente 250mg :
 $250 \times 0,01 = 2,5$ donc 250mg d'Aspégic est égal à 2,5ml de solution.
 Vous injectez donc 2,5ml de solution.

Exemple concret

Le médecin prescrit 1,5g de Kcl. On dispose dans le service d'ampoules de 10 ml de Kcl à 10%. Combien de ml faut-il prélever ?

10% signifie 10g pour 100 ml

$$10\text{g} \longleftrightarrow 100 \text{ ml}$$

$$1\text{g} \longleftrightarrow 10 \text{ ml}$$

$$\text{On a besoin de } 1,5\text{g donc : } 1\text{g} \longleftrightarrow 10\text{ml}$$

$$1,5\text{g} \longleftrightarrow ? \text{ ml}$$

Donc :

$$1\text{x} ?\text{ml} = 10\text{x}1,5$$

$$?\text{ml} = (10\text{x}1,5)/1$$

$$?\text{ml} = 15$$

Il faut donc prélever 15ml de Kcl dosé à 10% pour obtenir 1,5g de kcl

On a donc besoin de 1 ampoule et demi de Kcl.

2. Les débits

Le débit est le rapport d'un volume sur le temps. Le débit d'une perfusion s'exprime en gouttes par minutes.

$$d = \frac{Q}{t} = \frac{\frac{\text{volume(ml)} \times \text{nbrede gouttes}}{\text{ml}}}{\text{min} \times \text{temps}}$$

$$d = \frac{\text{nombre de gouttes}}{\text{minute}}$$

Pour le calculer, il faut se souvenir que pour : les solutés standard : 1ml = 20 gouttes, le sang : 1 ml = 15 gouttes, microdrip : 1 ml = 60 gouttes.

CHAPITRE 4 : TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION URINAIRE

GENERALITES

Les troubles du système uro-génital favorisent souvent l'apparition de stress et de problèmes émotifs. Un client (ou malade) peut se sentir coupable ou honteux lors d'exams ou de traitements de ses organes génitaux externes. S'il est incontinent, au dégoût peut se mêler un sentiment de détresse.

Chez l'homme, les interventions chirurgicales sur les organes génitaux sont perçues comme une atteinte à la virilité, peu importe l'âge. Aussi "les troubles de la prostate" avec son corollaire de difficultés sexuelles (troubles d'érection, éjaculation précoce etc.....) sont d'origine psychologique et ont des causes variées : inquiétude, culpabilité, incompatibilité avec le partenaire, fatigue etc...

A cause de ces craintes cachées, l'homme peut montrer de l'agressivité et l'hostilité envers ceux qui le soignent. Le client peut aussi rentrer en colère, ce qui a pour effet de décupler sa douleur. Les clients atteints d'infections urinaires répétées deviennent parfois dépressifs lorsqu'ils sont soumis à des traitements prolongés. L'anxiété dans toute situation de stress peut occasionner la pollakiurie et des mictions impérieuses.

Le client souffrant d'affection urogénital comme tous les autres clients, a besoin de sentir qu'il est respecté et que ses problèmes sont compris. Il veut que l'on réponde à ses questions, que ses peurs soient apaisées et que ses douleurs soient soulagées. Un des rôles importants de l'infirmier ou sage-femme est de rassurer le client, car ce type de client nécessite plus de soutien et de compréhension que les autres.

RECUEIL DES URINES POUR ANALYSE

OBJECTIF GENERAL

Connaitre le recueil des urines pour analyse.

OBJECTIF SPECIFIQUES

Prélever les urines chez un client.

INTRODUCTION

L'analyse d'urines fournit un grand nombre de renseignements. Généralement et normalement, on effectue une analyse d'urines à l'admission du patient ou avant une intervention chirurgicale. Elle comprend l'évaluation des points suivants :

1. la couleur et la limpidité (limpide ou claire)
2. l'odeur
3. Le PH et la densité
4. Recherche de protéine (protéinurie), de glucose (glycosurie) et de corps cétoniques (cétonurie).
5. Examen microscopique du sédiment pour déceler la présence de globules rouges, de globules blancs, de cylindres, de cristaux, de pus et de bactéries (ECBU) ;
6. Faire un antibiogramme en vue d'instituer un traitement.

NB :

En présence de certains symptômes, on utilise une bandelette réactive pour dépister rapidement la présence d'hémoglobine, de corps cétoniques, de glucose, de protéine et leucocytes. De nombreuses autres analyses peuvent être faites dans des situations particulières.

COMMENT PRELEVER LES URINES ?

- Effectuer toujours les analyses d'urines sur un échantillon d'urines frais, recueilli de préférence lors de la première miction du matin, car ces urines sont concentrées et susceptibles de révéler des anomalies ;
- Il faut réfrigérer les échantillons d'urines aussitôt après prélèvement à 4°C ;
- Laisser à la température de la pièce, les urines deviennent alcalines à cause de la décomposition de l'urée par les bactéries ;
- Si les urines ne sont pas réfrigérées, l'examen doit être fait dans les 30mn qui suivent le prélèvement ;
- Tout retard entraîne la dissolution des éléments cellulaires et une prolifération bactérienne dans les échantillons non stériles.

SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION DIGESTIVE

CONTROLE DE L'EVACUATION INTESTINALE RECUEIL ET SURVEILLANCE DES SELLES

OBJECTIF GENERAL

Connaître le contrôle l'évacuation intestinale- Recueil et surveillance des selles.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir l'évacuation intestinale.
2. Déterminer le rôle de l'Infirmier et de la sage-femme en cas d'anomalie des selles.
3. Identifier les anomalies des selles.
4. Effectuer la surveillance des selles.
5. Expliquer les caractéristiques des selles.

INTRODUCTION

L'infirmier ou la sage-femme doit savoir : la couleur la consistance et la teneur des selles, en noter la fréquence, les anomalies afin d'y remédier au plus vite.

I. LES CARACTERISTIQUES NORMALES DES SELLES

1. La couleur

Les selles normales sont de couleur brun foncé chez l'adulte, jaune or chez l'enfant nourri au sein, mastic ou blanc pur : par l'absence de bile (ictère)

- Verdâtre : diarrhée infantile grave en cas d'alimentation artificielle (toxicose).
- Noir : présence de sang digéré, dégluti après hématomèse, ou épistaxis.
- Rouge : présence de sang (hémorragie intestinale ou rectorragie, hémorroïde, cancer).

NB : Les médicaments à base de bismuth ou de fer donnent des selles noires.

2. La consistance

Les selles normales sont moulées chez l'adulte pâteuse chez le nourrisson.

Sèche : encore appelés scybale = accumulation dans l'intestin d'excréments durs et arrondies par suite de constipation. L'accumulation des matières peut être énorme et peut dissimuler une tumeur intestinale appelé fécalome.

3. L'odeur

Les selles peuvent être plus ou moins fétides.

II. LES ANOMALIES DES SELLES ; RECUEIL ET SURVEILLANCE

• Les anomalies des selles :

- Toutes les selles qui présentent une anomalie doivent être gardées pour être présentées au médecin.
- Les selles glaireuses : dans les colites (infection du colon).
- Les selles muco-purulentes : dysenterie.
- Les selles pâteuses : amibiase chronique.
- Les selles séreuses : la diarrhée séreuse est très liquide ; elles peuvent ressembler à une purée verdâtre ou décoloré semblable à du bouillon sale ou contenir des grumeaux ou des grains, riziformes par exemple dans le choléra.
- Les diarrhées cholériformes sont particulièrement graves chez le nourrisson.
- Enfin les selles peuvent contenir des vers intestinaux, ascaris, ténias, oxyures etc.

• Prélèvement des selles

Les selles fraîchement émises sont recueillies au moyen d'une boîte ou d'un flacon à large bord. Le prélèvement des selles se fait dans les conditions prescrites (asepsie) :

- Fermer la boîte ou le flacon et mettre une étiquette portant le nom et prénoms du malade, son sexe, l'âge, l'examen demandé.
- Etablir un bulletin qui comporte l'identification du malade et la nature de l'examen demandé
- Acheminer les selles au labo sans trop tarder.

On prélève les selles pour différentes analyses : analyse clinique (recherche de sang), analyse bactériologique ou coproculture, analyse parasitologique.

• Surveillance des selles

Le bassin sera conservé dans le W.C et recouvert d'une serviette ou d'un papier hygiénique ou du papier journal. Les couches souillées du nourrisson devront être également conservées. Certains malades peuvent être contagieux par les selles : choléra, fièvre typhoïde, les selles de l'hépatite virale, etc.). Il faut alors un bassin personnel et veiller très attentivement à la désinfection des selles avant de les jeter (plusieurs fois avec du grésil par exemple). Nettoyage du bassin également. Assurer les soins sans manifester le dégoût désodoriser la chambre ou la salle.

III. LE RÔLE DE L'INFIRMIER OU DE LA SAGE-FEMME EN CAS D'ANOMALIE DES SELLES

L'infirmier ou la Sage-Femme devra observer :

- La fréquence des selles : le nombre de selles quotidienne.
- La régularité des selles : normalement le malade doit se présenter tous les jours aux toilettes : la couleur, l'odeur
- La présence d'éléments anormaux (pus, mucosités, parasites intestinaux.
- Assurer les soins de propreté, et renouveler les toilettes périnéales.
- Assurer la toilette relative au siège, Faire des massages (prévention d'escarre).
- Faire un change à tout malade souillé, Contrôler les selles de tout malade qui va sur le bassin et les garder (après les avoir couverts, si elles présentent des éléments (sang, vers intestinaux, etc.) Les présenter au médecin.

CONCLUSION

Rappelons que l'infirmier est directement en contact du malade et que son esprit à observer les anomalies au niveau des selles s'avère nécessaires et signe sa vigilance.

LES LAVEMENTS ÉVACUATEUR ET MÉDICAMENTEUX

OBJECTIF GÉNÉRAL

Connaître les lavements évacuateurs et médicamenteux.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. Définir le lavement évacuateur.
2. Enumérer les indications et contre-indications d'un lavement évacuateur.
3. Enumérer le matériel pour un lavement évacuateur ou médicamenteux.
4. Citer les incidents et accidents dans un lavement évacuateur.

INTRODUCTION

Les lavements en général constituent l'introduction par l'anus de liquide que l'on injecte dans l'intestin en plus ou moins grande quantité. Ils peuvent être de plusieurs ordres : évacuateur, médicamenteux pour examen radiologique. Le lavement n'est pas inoffensif et ne doit être donné que sur prescriptions médicales. L'infirmier ou la sage-femme pourvoira son tact et sa délicatesse dans l'administration d'un lavement en ménageant au mieux la pudeur du malade et de ses voisins.

I. DÉFINITION

Le lavement est l'introduction de liquide dans le rectum et dans le sigmoïde. Le lavement peut se faire dans un but évacuateur ou thérapeutique. Il est souvent administré pour évacuer les fesses et nettoyer l'ampoule rectale, puis le colon avant une intervention ou un examen.

II. INDICATIONS ET CONTRE - INDICATIONS

1. Lavement évacuateur

• Indications :

- Constipation chronique ;
- Avant une intervention chirurgicale sur le colon ;
- Avant certains examens radiologiques (rectoscopie) ;
- Avant l'accouchement.

• Contre-indications :

- Douleur abdominale accompagnée de fièvre ;
- Occlusion intestinale ;
- Traumatisme abdominal ; lors d'hémorragie intestinale ;
- Péritonites ;
- Appendicites ;
- Fistule vésiculo-rectale ou vésico-vaginale ;
- Déchirure périnéale.

2. Lavement médicamenteux

On donne le lavement médicamenteux rarement dans un but thérapeutique. Ce lavement doit être gardé, aussi doit-on le donner à basse pression et en petites quantités (200 cm³ maximum) afin d'éviter l'excitation intestinale.

Le lavement médicamenteux peut être antihelminthique, laxatif, sédatif, antispasmodique, anticonvulsif, hypnotique, etc.

3. Les différentes sortes de lavement médicamenteux

- Le lavement au choral (sédatif hypnotique et anticonvulsif).

Il peut se faire dans certains cas :

- Pendant l'accouchement ;
- Dans l'éclampsie puerpérale ;
- Dans le tétanos ;
- Dans les insomnies rebelles.

- Le lavement au bromure (idem)

- Le lavement bandonisé (se faisait autrefois dans :

- Les crises douloureuses herniaire ; aujourd'hui c'est le traitement chirurgical qui est préconisé) ;
- Menace de fausse couche ;
- Hémorragie de la jeune femme enceinte, calme les contractions de l'intestin, de l'utérus et la vessie.

III. MATERIEL

- Lavement évacuateur

- 1 bock à lavement
- 1 tuyau de caoutchouc de 1,50 m.
- Une canule de verre à laquelle on adapte la sonde rectale en caoutchouc ;
- Une pince de péan
- De la vaseline
- Un rétroforme
- Une alèze en toile
- Le liquide à injecter dont le volume varie suivant les indications thérapeutiques et l'âge.

- o Volume normal : ½ litre
- o 5 à 10 ans : 120 à 140 ml
- o 10 ans : 250 ml
- o Nourisson 40 à 80 ml.

La température minimum du lavement de 30 à 35°.

- Lavement médicamenteux (exemple lavement au choral : produit utilisé en radiographie pour lavement médicamenteux)

- 4 g de choral ;
- 50 g de lait ou d'huile d'infusion. Si le malade n'a pas eu de selles, lui donner une heure avant un lavement évacuateur ;
- Vérifier la dose prescrite par le médecin et faire chauffer au bain-marie.

IV. TECHNIQUE

- Lavement évacuateur (voir fiche d'apprentissage)

- Lavement médicamenteux

On donne le lavement médicamenteux rarement, dans un but thérapeutique. Le faire précéder d'un lavement évacuateur une heure avant.

- Préparer 20 à 30 gouttes de produit (chromure choral etc.) pour 125 g d'eau tiède. Cette solution doit être donnée avec une sonde fine et un bock ou une poire mais très lentement.

V. INCIDENTS ET ACCIDENTS POUVANT SURVENIR LORS DU LAVEMENT

Accidents

- Perforation du colon ou lésion du colon ;
- Syncope, arrêt cardiaque.

Incidents

- Irritation de la muqueuse rectale ;
- Crampes abdominales ;
- Brûlure.

CONCLUSION

Les lavements évacuateurs comme médicamenteux requiert un tact dans leur pratique car ils ne sont pas inoffensifs et doivent être donnés sous surveillance hospitalière.

SOINS INFIRMIERS DANS LA FONCTION RESPIRATOIRE

AIDE A LA VENTILATION

OBJECTIF GENERAL

A la fin de ce cours, l'étudiant de la licence 1, doit être capable d'expliquer le mécanisme de la ventilation chez un malade en état de détresse respiratoire.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir la ventilation en précisant ses variations pathologiques.
2. Expliquer les conditions d'une bonne ventilation en précisant les positions adaptées à sa prévention.
3. Citer au moins deux interventions infirmières spécifiques pour le traitement des difficultés respiratoires.

I. GENERALITES SUR LA VENTILATION

Qu'est-ce que la ventilation ? La ventilation est le degré d'introduction et d'expulsion d'air dans les poumons.

Quelles sont les différentes variations pathologiques de la ventilation ?

1. Hypoventilation :

C'est la réduction de la quantité d'air apporté aux poumons. Lorsque la ventilation alvéolaire est insuffisante pour aspirer l'oxygénation et l'alimentation de gaz carbonique (CO_2) la pression d'oxygène dans l'alvéole et le sang artériel diminuent, la pression de gaz carbonique (CO_2) s'élève.

1.1. Conséquences de cette situation

- Hypoxémie : diminution de la teneur du sang en oxygène (O_2) ;
- Hypercapnie : élévation du gaz carbonique (CO_2) dans le sang ;
- Acidose respiratoire : augmentation du taux d'acide dans le sang provenant d'une mauvaise ventilation.

1.2. Causes

- Dépression du centre respiratoire (médicaments anesthésiques) ;
- Atteinte des terminaisons nerveuses des muscles respiratoires ;
- Traumatisme du thorax ;
- Obstruction des voies aériennes.

2. Hyperventilation alvéolaire

C'est l'augmentation de la quantité d'air envoyé aux poumons caractérisé par la respiration profonde et prolongée liées surtout à l'anxiété.

Elle survient quand l'apport en oxygène (O_2) et l'extraction du gaz carbonique (CO_2) sont supérieurs aux besoins métaboliques.

Les pressions d' O_2 alvéolaires et artérielles montent quand celles en gaz carbonique (CO_2) baissent ; elle est caractérisée par une expiration difficile.

Elle est provoquée par :

- un œdème aigu du poumon (OAP) ;
- un emphysème ;
- un cœur pulmonaire ;
- une crise d'asthme.

II. LES CONDITIONS D'UNE BONNE VENTILATION

1. Mettre le malade dans une position permettant une meilleure expansion thoracique.
2. Assurer au malade la liberté de ses voies aériennes ce qui aura pour avantages d'assurer la liberté de ses mouvements respiratoires et le libre passage de l'air de l'extérieur jusqu'aux poumons.
3. Faire tousser le malade et lui apprendre à respirer profondément afin d'éliminer les sécrétions.
4. Assurer au malade une hydratation nécessaire au maintien de l'humidité des muqueuses des membranes respiratoires car dans le cas d'une déshydratation ou lorsque le taux d'humidification de l'air ambiant est bas, l'expectoration se fait moins à cause de l'épaississement et de l'adhérence des sécrétions.
5. Promouvoir au malade de saines habitudes de santé et un environnement sain (dans sa chambre, ouvrir porte fenêtre et interdit de fumer).

III. DIFFERENTES POSITIONS A ADOPTER

1. Position Latérale de Sécurité

Elle permet d'éviter l'encombrement des voies respiratoires supérieures chez un malade inconscient en favorisant l'évacuation des mucosités, les vomissements ou du sang et en empêchant la langue de tomber en arrière dans le pharynx.

2. Position de Forolet ou Position Demi-Assise

Elle est souvent utilisée par les malades alités autant pour des raisons de confort que pour des raisons thérapeutiques. Elle offre une possibilité de changement de position agréable.

3. Position de décubitus dorsale

Elle est indiquée pour des malades ayant subi une intervention à la colonne vertébrale ou une anesthésie rachidienne.

4. Position de décubitus ventrale

C'est une position très confortable pour dormir.

Elle n'entraîne pas de flexion des hanches donc recommandée pour soulager des malades alités car elle maintient l'alignement normal des hanches. Un petit oreiller placé juste sous le diaphragme soutient la courbure lombaire et favorise la respiration.

IV. INTERVENTIONS SPECIFIQUES POUR LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES RESPIRATOIRES

- Le drainage de posture ;
- L'oxygénothérapie ;
- Les ventilations artificielles :
 - o Méthode orale ;
 - o Méthode mécanique.

OXYGENOTHERAPIE

OBJECTIF GENERAL

A la fin de ce cours, l'étudiant de la licence 1 doit être capable de réaliser l'oxygénothérapie.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

1. Définir l'oxygénothérapie.
2. Décrire les indications et contre-indications de l'oxygénothérapie.
3. Citer le matériel de l'oxygénothérapie en spécifiant les sources et les appareils de distribution.
4. Assurer la surveillance d'un client sous oxygénothérapie.
5. Citer les accidents et incidents lors d'une oxygénothérapie

INTRODUCTION

La respiration est une fonction vitale qui fait appel au besoin de respirer. La perturbation de l'équilibre de ce besoin fondamental entraîne une dépendance respiratoire, nécessitant une suppléance. La satisfaction de ce besoin exige entre autres l'oxygénothérapie.

I. DEFINITION

L'oxygénothérapie est une méthode de traitement ou réanimation artificielle qui consiste à enrichir l'air inspiré en oxygène pour assurer une hématoxémie normale dans un but thérapeutique.

II. INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

1. Indications

- Tous les cas d'Anoxie.

1.1 Anoxie anoxémique

La teneur de l'hémoglobine en oxygène est insuffisante au cours du transit pulmonaire dû à :

- La chute de la pression de l'oxygène dans l'air inspiré ;
- L'obturation des voies respiratoires : submersion, pendaison, corps étrangers... ;
- Insuffisance des muscles respiratoires par atteinte des centres nerveux ;
- Les affections broncho-pulmonaires, telles que : bronchite, asthme, broncho-pneumonie, emphysème ;
- Etat de choc ; dans toutes interventions chirurgicales.

1.2 Anoxie anémique

Elle est traduite par le manque d'oxygène à la suite d'anémie. Il y a insuffisance de l'hémoglobine circulante pour assurer le transfert de l'oxygène.

Cette insuffisance est causée par :

- des hémorragies massives ;
- des anémies sévères ;
- des intoxications à l'oxyde de carbone pour donner un composé stable : la carbohémoglobine.

1.3 Anoxie histotoxique

L'oxygène est mal utilisé au niveau des tissus. Cette mauvaise utilisation se rencontre dans les intoxications comme :

- Intoxication au barbiturique ;
- Intoxication au cyanure ;
- Intoxication à l'alcool.

2. Contre-indications

- Les obstacles sur les voies respiratoires
- Les paralysies des muscles respiratoires

Ces contre-indications ne sont pas formelles ; en effet l'oxygène doit être utilisé avec précaution chez : les grands insuffisants respiratoires chroniques et les cœurs pulmonaires bulbaires sont devenus sensibles : non pas à l'hypercapnie (élévation CO_2 dans le sang) mais à la hypoxie (diminution de l'oxygène dans le sang).

NB : L'oxygénothérapie en augmentant le taux de l'oxygène dans le sang entraîne une diminution des stimulations et peut provoquer une apnée.

III. MATERIEL

1. Sources :

L'oxygène peut être fourni par :

Une distribution collective : Dans ce cas il faut un débitmètre branché sur une prise murale permettant de contrôler le nombre de litre distribué à la minute.

Une distribution individuelle par obus ou bombonne d'oxygène sous pression de 100 000 litres comprimé à la pression 150 litres / cm^3 .

Ici la distribution est assurée par :

- Un manodétendeur adapté à l'obus permettant d'abaisser la pression ;
- Un débitmètre ;
- Une tuyauterie ;
- Un humidificateur ou barboteur.

L'utilisation d'un obus d'oxygène nécessite certaines précautions :

- Ne jamais graisser les robinets, les raccords, les détendeurs car l'association corps gras + oxygène est un mélange détonnant (explosion) ;
- Transporter l'obus d'oxygène sur des chariots spécialement conçus où ils sont immobilisés verticalement à l'aide de courroies.

Principes communs de l'appareil de distribution

- Le débit
 - Adulte : 6 à 8 litres/mn ;
 - Enfant : 3 à 6 litres/mn.
- L'oxygène doit être humidifié par :
 - Passage dans un flacon barboteur rempli d'eau au $\frac{3}{4}$;
 - Passage sur la glace ;
 - L'association avec aérosolthérapie.

L'oxygène peut être administré en continue et en discontinue

2. Le masque d'oxygène de BINET. BOCHET

Il est transparent et permet la surveillance du faciès. Il est utilisé dans les grandes concentrations d'oxygène.

- Mise en place : brancher d'abord, régler le débit avant de l'ajuster sur le visage du patient.
- Entretien : le laver à l'eau savonneuse et le rincer.
- Désinfection : à l'aide d'un tampon de coton imbibé de solution de formol à 10%

NB : Ne jamais utiliser pour le désinfecter, de l'eau de javel, de l'éther ou de l'alcool qui peuvent le détériorer.

3. Les sondes rhino-pharyngées

Utilisées dans les débits d'oxygène faibles ou moyens. Ils consistent à utiliser des sondes en Nélaton n° 8 reliée par un raccord de verre en Y.

La longueur à introduire est évaluée en mesurant l'extrémité du nez (narine) au lobe de l'oreille.

- Humidifier la sonde avec de l'eau ou du sérum physiologique.
- Glisser doucement la sonde dans une narine jusqu'à la longueur mesurée.
- Fixer la sonde avec du sparadrap sur les ailes du nez.
- La faire remonter sur la joue pour la fixer sur la tempe.
- Changer la sonde régulièrement toutes les 8 heures en changeant de narine.

4. Les lunettes à oxygène.

La tente à oxygène.

Elle se compose de la tente tendue par un cadre métallique, un bac à glace, une trompe à air permettant le passage de l'air et sa réfrigération par le passage sur la glace.

IV. SURVEILLANCE

L'oxygénothérapie doit faire disparaître tous les signes d'anoxie. Elle portera en général sur la disponibilité de l'oxygène, la présence d'eau dans l'humidificateur, établir une feuille de surveillance, s'assurer de la liberté des voies respiratoires.

Le débit : Il doit être adapté à l'âge et au type de la détresse respiratoire.

1. Les signes cliniques :

Aspects des téguments : La peau, les conjonctives qui étaient cyanosées, pâles reprennent la coloration normale rosée. Les sueurs disparaissent ; si persistance de sueur sous la tente : Vérifier le bac à glace.

2. Les signes généraux

- Le pouls accéléré, filant se régularise ;
- La tension Artérielle élevée chez le malade en hypercapnie, baisse ou effondrée chez le malade choqué redevient normale ;
- La respiration rapide, superficielle devient calme, régulière.

3. Les signes neuropsychiques

Malade agité, angoissé, s'apaise ;

V. ACCIDENTS-INCIDENTS

1. Accidents

Rares et dus à des erreurs de technique : Ces erreurs sont :

- oxygène sous trop forte pression
- oxygène non humidifié
- accident pulmonaire : desquamation alvéolaire pouvant entraîner un OAP
- accident oculaire : cécité par fibrose oculaire chez le prématuré
- accident nerveux : excitation des centres nerveux bulbares chez l'insuffisant respiratoire chronique se traduisant par une apnée (arrêt respiratoire).

2. Incidents

- Blessure de la muqueuse nasale ;
- Fosse route ;
- Saignement traumatique.

CONCLUSION

L'oxygénothérapie est certes un traitement précieux en cas de détresse respiratoire ou état d'anoxie mais ne doit pas faire oublier l'étiologie de l'anoxie. Le rôle de l'infirmier s'avère capital dans la surveillance de cette méthode de traitement.

NOTIONS D'URGENCES MEDICALES INFIRMIERES

Cours de soins infirmiers sur les urgences médicales dans les pathologies :

- **CARDIO-VASCULAIRES**
- **DIGESTIVES**
- **URINAIRES**
- **EN RHUMATOLOGIE**
- **LE COMA**
- **LE COMA DIABÉTIQUE**

I. URGENCES CARDIO-VASCULAIRES

Ces cours portent sur l'identification rapide des signes de détresse circulatoire et la mise en œuvre de protocoles de réanimation.

- **Le Syndrome Coronarien Aigu (SCA)**
- **L'Arrêt Cardio-Respiratoire (ACR)**
- **Les Troubles du Rythme et de la Conduction**
- **L'Insuffisance Cardiaque Aiguë**
- **Les Pathologies Vasculaires**
- **L'Hypertension Artérielle (HTA) maligne**

L'accent est mis sur la surveillance de l'abdomen aigu et la préparation préopératoire d'urgence.

II. URGENCES DIGESTIVES

- **L'Hémorragie Digestive**
- **L'Abdomen Aigu Chirurgical**
- **Le Syndrome Occlusif**
- **Les Pathologies Bilio-pancréatiques**
- **Traumatismes Abdominaux**

III. URGENCES URINAIRES / UROLOGIQUES

Les cours traitent principalement de l'obstruction, de l'infection sévère et de la défaillance rénale.

- **La Colique Néphrétique**
- **La Rétention Aiguë d'Urine (RAU)**
- **Les Infections Urinaires Graves**
- **L'Insuffisance Rénale Aiguë (IRA)**
- **Urgences Scrotales**

IV. URGENCES EN RHUMATOLOGIE

Bien que moins fréquentes, elles engagent parfois le pronostic fonctionnel ou vital (infection).

- Arthrite Septique

- La Compression Médullaire et Syndrome de la Queue de Cheval :
- Les Accès Microcristallins Hyperalgiques
- Les Vascularites et Pathologies Systémiques
- Les Fractures Pathologiques

V. NEUROLOGIE

- Le coma
- Le Diabète/ Coma Diabétique

Éléments transversaux à ces cours :

- Calculs de doses et débits (adrénaline, anticoagulants, antalgiques paliers 3).
- Surveillance des paramètres vitaux (score de NEWS, monitoring).
- Transmission ciblée et collaboration avec le médecin urgentiste ou réanimateur.

VI. URGENCES CARDIO-VASCULAIRES

• LE SYNDROME CORONARIEN AIGU (SCA)

Introduction

Le Syndrome Coronarien Aigu (SCA) regroupe l'ensemble des manifestations cliniques liées à une ischémie myocardique aiguë. Il représente l'une des principales causes de morbi-mortalité dans les pays industrialisés et constitue le motif d'urgence cardiovasculaire le plus fréquent.

L'enjeu du diagnostic

Le pronostic du patient repose entièrement sur la rapidité de la prise en charge. Le rôle de l'infirmier(e) est ici déterminant, tant dans l'identification précoce des signes cliniques que dans la mise en œuvre immédiate des protocoles de soins.

Les trois piliers de la prise en charge

1. **Le temps** : Chaque minute de perdue correspond à une perte irréversible de cellules musculaires cardiaques (nécrose).
2. **L'ECG** : C'est l'outil de tri fondamental qui sépare l'urgence absolue (obstruction totale) de l'urgence relative (obstruction partielle).
3. **La surveillance** : Le risque de complications rythmiques mortelles (arrêt cardiaque) est maximal durant les premières heures.

Souhaites-tu que j'ajoute également une section sur l'anatomie des artères coronaires pour bien comprendre la localisation de l'infarctus à l'ECG ?

1. Définition et Physiopathologie

Le SCA est la conséquence de l'obstruction (partielle ou totale) d'une artère coronaire par la rupture d'une plaque d'athérome, entraînant une ischémie du muscle cardiaque.

On distingue deux types principaux selon l'ECG :

- **SCA ST+ (STEMI)** : Occlusion totale. Urgence de reperfusion immédiate.
- **SCA ST- (NSTEMI)** : Occlusion partielle ou intermittente.

2. Sémiologie (Signes cliniques)

L'interrogatoire est crucial. La douleur thoracique typique présente les caractéristiques suivantes :

- **Siège** : Rétro-sternale (derrière le sternum).
- **Type** : Constrictive (sensation d'étau, de broiement).
- **Irradiations** : Bras gauche, mâchoire, dos ou les deux épaules.
- **Durée** : Supérieure à 20 minutes, ne cédant pas au repos ni à la Trinitrine.
- **Signes associés** : Sueurs profuses, nausées/vomissements, angoisse importante (« sensation de mort imminente »), dyspnée.

Note : Chez les femmes, les personnes âgées et les diabétiques, les symptômes peuvent être atypiques (douleurs épigastriques, simple malaise, essoufflement isolé).

3. Prise en charge infirmière immédiate

• Évaluation et monitoring

1. **Repos strict au lit** : Installation en position demi-assise (diminue le retour veineux et facilite la respiration).
2. **Monitoring (Scope)** : Surveillance de la fréquence cardiaque, PA, saturation en O₂ et surtout recherche de troubles du rythme (FV/TV).
3. **ECG 12 dérivations** : À réaliser en moins de 10 minutes dès l'arrivée. C'est l'examen clé.

• Actions thérapeutiques (sur prescription)

4. **Pose de deux voies veineuses périphériques (VVP)** : Garde-veine avec du sérum physiologique.
5. **Oxygénothérapie** : Uniquement si SpO₂ < 90%.
6. **Bilan biologique** : Dosage de la Troponine (marqueur de la nécrose myocardique), bilan d'hémostase, ionogramme.
7. **Traitement médicamenteux (Protocole "BASIC")** :
 - Bêta-bloquants (selon la tolérance).
 - Antiagrégants plaquettaires (Aspirine + inhibiteur P2Y₁₂ comme le Clopidogrel ou Ticagrelor).
 - Statines.
 - Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC).
 - Contrôle des facteurs de risque (et Anticoagulation/Héparine).

4. Stratégies de Reperfusion (SCA ST+)

Si le diagnostic de SCA ST+ est posé, l'objectif est de "déboucher" l'artère :

8. **Angioplastie primaire (PCI)** : Passage d'un ballonnet et pose de stent. C'est la méthode de référence si elle est accessible en moins de 120 min.
9. **Thrombolyse (Fibrinolyse)** : Injection d'un médicament pour dissoudre le caillot (si l'angioplastie est trop éloignée).

5. Rôle IDE et Surveillance

En tant qu'infirmier(e), votre surveillance porte sur :

Paramètre	Risque / Complication
Douleur	Persistance de l'ischémie ou ré-occlusion.
ECG	Troubles du rythme (risque d'arrêt cardiaque) ou retour du segment ST à la ligne isoélectrique.
Hémodynamique	Choc cardiogénique (chute de la PA, marbrures, oligurie).
Point de ponction	Si angioplastie : risque d'hématome ou d'hémorragie au point de ponction fémoral ou radial.

6. Éducation du patient

Règles hygiéno-diététiques : Arrêt du tabac (priorité absolue), régime méditerranéen.

Activité physique : Reprise progressive (souvent via une réadaptation cardiaque).

Observance : Expliquer l'importance des antiagrégants pour éviter la thrombose de stent.

Souhaites-tu que je détaille davantage la lecture de l'ECG (les différentes dérivations et les territoires du cœur) ou que je te prépare un petit QCM d'entraînement sur ce cours ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

LIVRES

1. **Brunner SUDDARTH** : Soins Infirmiers en Médecine et Chirurgie 1985
Edition de renouveau pédagogique
2. **Guide et protocole de soins infirmiers obstétricaux en santé communautaire**
3. **Communauté des filles de la charité** : soins infirmiers aux malades Tome 1 Nouvelle édition 75006 Paris (1983) 890 pages
4. **Technique de soins** : Générales et médicales par un comité de gradués en nursing 2^{ème} édition (1957)
5. **Soins et pratiques** : Théories et pratiques : Ottawa, Canada 2^{ème} édition
6. **Soins et pratiques** : Guide médical africain ; Médecine tropicale 8^{ème} édition
7. **BOUVENOT B et Coll** : Pathologie médicale, Masson Editeur, 1985.
8. **HARLAY A. et Coll.** : Surveillance infirmière, Edition Lamarre Poinat, 1989.
9. **MELTZER Suzanne et Coll.** : Soins infirmiers en Médecine et en chirurgie 3^è Edition 1994
10. **Site internet**
http://www.infirmiers.com/ressources/infirmieres/protocole_fiche_technique_sondage-vesical-htmn.